

Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas

Taller regional

Ciudad de Panamá, 11-15 de septiembre del 2023

Informe de la reunión

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas

Taller regional

Ciudad de Panamá, 11-15 de septiembre del 2023

Informe de la reunión

Washington, D.C., 2024

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas. Taller regional. Ciudad de Panamá, 11-15 de septiembre del 2023. Informe de la reunión

OPS/HSS/HR/24/0010

© Organización Panamericana de la Salud, 2024

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Índice

Agradecimientos	vii
Abreviaciones.....	viii
Introducción	1
Primera parte. Información general sobre el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	3
Temas abordados	3
Países y organizaciones participantes.....	3
Segunda parte. Contenido y objetivos del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”	5
Apertura	6
Módulo 1. Panorama global y regional de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	7
Agenda global. Cuentas nacionales del personal de salud.....	7
Perspectiva y prioridades regionales: evidencia, información y conocimiento en recursos humanos para la salud.....	7
Panorama regional: datos e información sobre los recursos humanos para la salud.....	8
Módulo 2. Experiencias de desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en países de la Región de las Américas.....	8
Brasil: Sistema único de salud y sistema de información de la fuerza de trabajo en salud	8
Cuba: Registro de profesionales y técnicos de la salud	9
Barbados: Sistema de información de recursos humanos	9
Canadá: Sistema de datos e información de recursos humanos para la salud	10
Haití: Desarrollo del sistema de información de recursos humanos para la salud en las Américas	10
Módulo 3. Reconocimiento de las cuentas nacionales del personal de salud	11
Cuentas nacionales del personal de salud, mapeo de fuentes de datos y actores, y metodología de medición	11
Ejercicio práctico: temas críticos.....	12

Módulo 4. Metodología del mapeo de ocupaciones para el desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	13
Chile: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud.....	13
Costa Rica: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud.....	13
Jamaica: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud.....	14
Suriname: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud.....	14
Mapeo de ocupaciones a nivel regional	15
Ejercicio práctico: Mapeo de ocupaciones.....	15
Módulo 5. Metodología del mapeo de actores para el desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	16
Belice: Mapeo de los actores en el sistema de recursos humanos para la salud.....	17
El Salvador: Cuentas nacionales del personal de salud para el año 2022	17
Paraguay: Sistema nacional integrado de información en recursos humanos para la salud. Características, procesos y avances	18
Mapeo de actores a nivel regional	18
Ejercicio práctico: Mapeo de actores.....	19
Módulo 6. La Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe.....	19
La Comisión del Caribe de Recursos Humanos para la Salud	19
Del Grupo de Acción a la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe: una visión general	20
Indicadores básicos de recursos humanos para la salud en el Caribe	20
Módulo 7. Metodología de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud.....	21
Sistemas de información para la salud. Marco conceptual, modelo de madurez de los sistemas de información para la salud y desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud de las Américas.....	21
Bahamas: El Comité Nacional de Recursos Humanos y Trabajadores de la Salud	23
Panamá: El sistema de información de recursos humanos de salud: un pilar fundamental en el desarrollo del sistema de salud y la construcción de políticas	23
Uruguay: Evaluación de la madurez del sistema de información	24
Presentación de la propuesta del modelo de madurez del sistema de información de recursos humanos para la salud a nivel regional.....	24
Ejercicio práctico: Modelo de madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	25

Desafíos y prioridades de los países de América Latina	27
Bolivia (Estado Plurinacional de)	27
Chile	27
Costa Rica.....	27
Cuba	28
Ecuador	28
Guatemala	28
Panamá	28
Paraguay.....	28
Perú	29
República Dominicana	29
Uruguay	29
Desafíos y prioridades de los países del Caribe y Canadá	31
Anguila	31
Antigua y Barbuda	31
Bahamas	31
Barbados.....	31
Belice.....	32
Canadá	32
Dominica	32
Granada.....	32
Guyana	32
Islas Turcas y Caicos	32
Islas Vírgenes Británicas	32
Jamaica	32
Montserrat	33
Saint Kitts y Nevis	33
San Vicente y las Granadinas	33
Santa Lucía	33
Suriname.....	33
Trinidad y Tabago.....	33

Cuarta parte. Resultados y conclusiones

37

Breve síntesis sobre el desarrollo del taller.....	37
Resultados.....	37
Conclusiones.....	37
Recomendaciones	38

Anexos

39

Anexo 1. Agenda del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” para los países de América Latina, 11-13 de septiembre de 2023	39
Anexo 2. Agenda del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” para los países del Caribe inglés, Canadá y Estados Unidos, 13-15 de septiembre de 2023.....	42
Anexo 3. Representantes de los distintos puntos focales en el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023.....	45

Imágenes

1 Miembros del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023	4
2 Apertura del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023	6
3 Participantes del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” durante el ejercicio práctico grupal, Panamá, 2023	12
4 Actividad de trabajo grupal durante el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023	16
5 Presentación del modelo de madurez IS4H en el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023	22
6 Captura de pantalla de la herramienta diseñada para evaluar la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud, Panamá, 2023	25
7 Participantes del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, durante el trabajo grupal, Panamá, 2023	26

Cuadros

1 Módulos del taller y su vinculación con los resultados.....	6
2 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en los países de América Latina, por orden de prioridad, 2023	30
3 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en el Caribe y Canadá, por orden de prioridad, 2023.....	34

Agradecimientos

Este documento lo ha elaborado la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la dirección de Benjamín Puertas. La coordinación de este esfuerzo estuvo a cargo de Gisele Almeida, asesora en evidencia y conocimiento de recursos humanos para la salud de la OPS, con el apoyo de Isabel Duré, Joel Caraballo, Annella Auer, Ana Paula Cavalcante de Oliveira y Mariana Lopes Galante, todos de la OPS.

Abreviaciones

ABS	Oficina de Estadísticas de Suriname, por su sigla en neerlandés
AMLS	análisis del mercado laboral de salud
APS	atención primaria de la salud
CARICOM	Comunidad del Caribe
CIHI	Instituto Canadiense de Información sobre la Salud, por su sigla en inglés
CIUO	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CIUO-08	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008
CNPS	cuentas nacionales del personal de salud
COVID-19	enfermedad por el coronavirus del 2019
CVSP	Campus Virtual de Salud Pública
FISO	sistema de información del Gobierno de Suriname, por su sigla en inglés
FTS	fuerza de trabajo en salud
HRH-ATF	Grupo de Acción en Recursos Humanos para la Salud, por su sigla en inglés
HSS-HR	Equipo de Evidencia e Información de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, por su sigla en inglés
IS4H	Sistemas de Información para la Salud, por su sigla en inglés
IS4H-MM	modelo de evaluación de madurez
JaHRvis	sistema de información y visualización sanitaria de Jamaica, por su sigla en inglés
MINSAP	Ministerio de Salud Pública
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
RHS	recursos humanos para la salud
SE-COMISCA	Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
SIGRH	sistema de información de recursos humanos para la salud, por su sigla en francés
SINARHUS	sistema nacional de información en recursos humanos para la salud de Costa Rica
SIRHS	sistemas de información de recursos humanos para la salud

Introducción

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son una herramienta fundamental para la buena gestión de los recursos humanos para la salud (RHS), así como para sustentar la implementación de políticas basadas en información y evidencia. Sin embargo, muchos países de la Región de las Américas enfrentan dificultades para contar con un SIRHS integrado que permita monitorear de forma efectiva el mercado de trabajo de la salud. La falta de información oportuna, precisa y pertinente para la gestión plantea limitaciones para analizar y comprender la formación, el tamaño, la composición, la calificación y la distribución de la fuerza laboral en salud, tanto a nivel nacional como subnacional, y su planificación en ese ámbito.

Por otra parte, se observa un incremento de los datos en el sector de la salud, almacenados en diversos registros y fuentes fragmentados, que dificultan la construcción y la gobernanza de los sistemas de información. Una mayor articulación interna y con la plataforma de las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) podría mejorar la coordinación programática de los países y fomentar prácticas homogéneas.

El trabajo realizado por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2021 ha permitido identificar algunos puntos clave para la cooperación técnica, con el objetivo de apoyar a los países en el desarrollo de sus sistemas de información y en el cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel regional y global. En primer lugar, identificar los niveles de madurez de cada uno de los sistemas permitirá orientar las acciones de cooperación a nivel nacional. Además, en un campo tan intersectorial y fragmentado como el de la fuerza laboral en salud, los datos los gestionan distintos actores gubernamentales, como la autoridad nacional de salud y de los servicios de salud, el sector privado, la seguridad social, los colegios profesionales y otros actores específicos de cada país. Contar con una visión amplia de este mapa de actores facilitará la identificación de estrategias para establecer alianzas adecuadas que favorezcan el intercambio de información.

Para gestionar de manera efectiva la fuerza laboral en salud y mejorar el monitoreo de la información, es esencial llevar a cabo un análisis del mercado laboral de salud (AMLS). Esto implica identificar tendencias y proporcionar una comprensión integral de los factores clave que afectan la oferta y la demanda de trabajadores de la salud, a fin de mejorar la previsión y la planificación de las necesidades futuras y orientar las estrategias a corto plazo para abordar problemas inmediatos. Por lo tanto, al iniciar un AMLS en un país, es crucial evaluar primero la implementación de las CNPS. Dependiendo de la situación, puede ser recomendable fortalecer la implementación de las CNPS, utilizando la red de actores involucrados.

En el ámbito global, el trabajo realizado para dar respuesta a los requerimientos de las CNPS, ha revelado particularidades en algunas profesiones, que no se ajustan fácilmente a las categorías presentes en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La diversidad de profesiones, denominaciones y regulaciones entre países requiere de un estudio específico en la Región para facilitar su comprensión y comparabilidad.

Las diferencias en los SIRHS a nivel regional ofrecen oportunidades para compartir buenas prácticas sobre estos temas. El intercambio entre países puede enriquecer las perspectivas y opciones de construcción de sistemas de información. Por ello, se ha considerado oportuno llevar a cabo el taller subregional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” (imagen 1) para abordar temas clave para el desarrollo y la consolidación de los SIRHS, tanto a nivel nacional como regional y global, y para fomentar la construcción de una comunidad de práctica y la identificación de acciones de cooperación entre países.

Este informe consta de cuatro partes que abordan los aspectos generales, el desarrollo, los desafíos y las prioridades de los países de la Región, así como los resultados y las conclusiones del taller.

PRIMERA PARTE

Información general sobre el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”

Objetivo general

Abordar temas clave para el desarrollo y la consolidación de los SIRHS a nivel nacional, así como para su integración a nivel regional y global.

Objetivos específicos

- Definir una metodología para el mapeo de las ocupaciones de la salud en la Región.
- Identificar a los actores involucrados en la construcción de los SIRHS en los países de las Américas.
- Validar una metodología para la evaluación de la madurez de los SIRHS.
- Actualizar la situación de las CNPS a nivel regional y global.
- Identificar el concepto y los pasos de un AMLS.
- Introducir el uso de las CNPS para informar los AMLS en el contexto de las Américas.

Temas abordados

- Marco global y regional de los SIRHS.
- CNPS a nivel regional y global.
- Mapeo de las ocupaciones de la salud en la Región.
- Mapeo de actores involucrados en la construcción de los SIRHS en los países de las Américas.
- Evaluación de la madurez de los SIRHS.

Países y organizaciones participantes

Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), y OPS (para más información, véase el anexo 3).

IMAGEN 1 Miembros del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023



© OPS

SEGUNDA PARTE

Contenido y objetivos del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”

Esta segunda parte presenta en detalle el contenido del taller y aborda cada uno de los objetivos específicos orientados a alcanzar los siguientes resultados:

- **R1.** Análisis de la situación de los SIRHS a nivel regional y global.
- **R2.** Presentación del marco de las CNPS e intercambio de experiencias entre países.
- **R3.** Introducción a la metodología para el mapeo de las ocupaciones en el ámbito de la salud y ejercicios prácticos sobre su utilización.
- **R4.** Presentación de una propuesta de metodología para el mapeo de los actores involucrados en la construcción de los SIRHS.
- **R5.** Presentación de una metodología validada para la evaluación de la madurez de los SIRHS.

Para alcanzar estos resultados, durante el desarrollo del taller se establecieron una serie de módulos específicos (cuadro 1).

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo en cada uno de los módulos, así como las participaciones de los distintos países y los trabajos realizados a nivel regional y global. Cada módulo incluye presentaciones, actividades grupales, discusiones e intercambios.

Para facilitar el trabajo colaborativo y disponer de una memoria de las jornadas, se utilizó el espacio de la comunidad de práctica “Fortalecimiento de sistemas de información de recursos humanos para la salud”, disponible en el Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS. En este espacio se recopilan las presentaciones y los registros de las discusiones de todas las jornadas del taller: <https://campus.paho.org/mooc/course/view.php?id=290§ion=0>.

CUADRO 1 Módulos del taller y su vinculación con los resultados

Módulo	Denominación	Resultado
Apertura	Introducción y presentación	-
Módulo 1	Panorama global y regional de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS)	R1
Módulo 2	Experiencias de desarrollo de SIRHS en países de la Región de las Américas	R1
Módulo 3	Reconocimiento de las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS)	R2
Módulo 4	Metodología del mapeo de ocupaciones para el desarrollo de los SIRHS	R3
Módulo 5	Metodología del mapeo de actores para el desarrollo de los SIRHS	R4
Módulo 6	La Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe	R1
Módulo 7	Metodología de evaluación de la madurez de los SIRHS	R5

Fuente: OPS.

Apertura

La apertura del taller estuvo a cargo del jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la OPS, Benjamín Puertas; la asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/Organización Mundial de la Salud (OMS) en Panamá, Leah-Mari Richards, y el jefe del Departamento de Planificación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Panamá, Dagoberto Vega (imagen 2).

IMAGEN 2 Apertura del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023



© OPS

Desde el inicio, se subrayó la importancia de los SIRHS en pos de mejorar la toma de decisiones y reducir las brechas de RHS, y en el camino hacia sistemas de salud resilientes. En este contexto, se presentaron los objetivos, la agenda, la metodología y los productos esperados, destacando la participación activa de los países.

Gisele Almeida, asesora en evidencia y conocimiento de recursos humanos para la salud de la OPS, coordinadora del Equipo de Evidencia e Información de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud (HSS-HR, por su sigla en inglés) de la OPS y coordinadora del taller, presentó a los representantes de los países, quienes afirmaron su presencia con el saludo de sus respectivas banderas.

Finalmente se compartió un video sobre la historia de la fundación de la OPS en las Américas y su relación con Panamá.

Módulo 1. Panorama global y regional de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Durante este módulo, los asesores de los SIRHS de la OPS expusieron el panorama regional y global mediante las siguientes tres presentaciones.

Agenda global. Cuentas nacionales del personal de salud

Mathieu Boniol, asesor en Gestión de Estadísticas, Datos, Evidencias y Conocimiento del Departamento de Fuerza de Trabajo en Salud de la OMS, ofreció un panorama general de la situación mundial y regional del personal de salud. Subrayó la importancia que revisten las CNPS, al alinear la información del personal de salud con la gestión de datos, el diálogo entre los países y las políticas mundiales de la OMS en la materia.

En cuanto a la situación global de los RHS, expuso los desafíos vigentes, que incluyen una escasez estimada de RHS en 20 millones de trabajadores a nivel mundial, desequilibrios en las competencias del personal, migración masiva de RHS, distribución geográfica desigual, envejecimiento de los RHS, baja productividad del personal, educación insuficiente y escaso desarrollo de políticas específicas.

Sobre las CNPS, destacó la oportunidad que ofrecen para que los países mejoren progresivamente la disponibilidad, la calidad y el uso de datos a partir de un conjunto de indicadores que se espera adaptar a las necesidades de cada país. Desde esta perspectiva, las CNPS se presentan como una herramienta clave para una mejor planificación y toma de decisiones en los sistemas de salud. A nivel global, facilitan el monitoreo de la movilidad de los trabajadores de la salud, vinculándose con el *Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud*.

Finalmente, enfatizó que abordar estos retos requiere de un enfoque sistémico, basado en la colaboración multisectorial y la participación de múltiples actores interesados.

Perspectiva y prioridades regionales: evidencia, información y conocimiento en recursos humanos para la salud

Por su parte, Gisele Almeida ofreció una perspectiva regional sobre el desarrollo de los SIRHS. Destacó que estos sistemas representan una de las funciones clave para la gobernanza en salud, el diseño de políticas de RHS y la creación de capacidades en los países. Subrayó que América Latina y el Caribe enfrentan un déficit crónico de 600 000 profesionales de la salud, así como una distribución desigual de RHS en la Región, lo que limita las

posibilidades de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. En relación con los SIRHS, identificó problemas comunes en los países de la Región, como la fragmentación de datos sobre RHS, el acceso limitado a la información del sector privado o la falta de coordinación con otros sectores, factores que dificultan la recopilación de información sobre la distribución, movilidad, formación y competencias del personal de salud.

Respecto de las CNPS, Almeida coincidió con Boniol en que estas ofrecen una valiosa oportunidad al proporcionar definiciones metodológicas que pueden adaptarse a las necesidades y características de los países de la Región, lo que favorecería el fortalecimiento de los SIRHS. Por ello, es crucial que los países implementen y fortalezcan sus SIRHS para garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de datos en la toma de decisiones políticas, resolviendo al mismo tiempo otros desafíos ligados a la gestión de los SIRHS, como la alta rotación de personal calificado. Finalmente, propuso una hoja de ruta para la Región que incluye diferentes procesos: *i)* la evaluación de la madurez de los SIRHS; *ii)* el mapeo de ocupaciones para asegurar una categorización precisa de las profesiones; *iii)* el mapeo de actores para identificar a los productores y propietarios de los datos de RHS, y *iv)* el análisis del mercado laboral de la salud, a fin de identificar las tendencias y los factores clave que influyen en la oferta y demanda de los trabajadores de la salud.

Panorama regional: datos e información sobre los recursos humanos para la salud

Las integrantes del HSS-HR (Isabel Duré, Ana Paula Cavalcante de Oliveira y Mariana Lopes Galante) presentaron un análisis de los indicadores disponibles en las CNPS a nivel regional, así como los resultados de la encuesta realizada en el 2023 a los puntos focales que completaron dicha información. Destacaron que la densidad de RHS en las Américas se sitúa en 63,3 por cada 10 000 habitantes, lo que supera la meta establecida a nivel mundial de 44,5. Sin embargo, existen brechas significativas entre países, con 16 de ellos por debajo de la meta mundial, mientras que otros, como Cuba y Estados Unidos, elevan el promedio. En cuanto a la disponibilidad de personal de salud, las subregiones con más deficiencias son el Caribe y Centroamérica. Respecto de los resultados de la encuesta a usuarios de las CNPS, identificaron como principales desafíos la dificultad para recolectar datos, la baja calidad de estos y el acceso restringido únicamente a la información del sector público.

A continuación, presentaron una propuesta de 17 indicadores básicos priorizados para monitorear en la Región, con base en la factibilidad de su recolección y los compromisos regionales asumidos por los países para mejorar la disponibilidad, la calidad y la distribución de RHS en la Región. Tras la aprobación de este conjunto de indicadores, los países expresaron la necesidad de contar con mayor capacitación y más personal especializado para fortalecer los SIRHS.

Módulo 2. Experiencias de desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en países de la Región de las Américas

En este módulo, la perspectiva regional se enriqueció con las experiencias compartidas por varios países en relación con el desarrollo de sus SIRHS. Se invitó a Brasil y Cuba, como países referentes de América Latina, debido a sus avances en la gestión de RHS, así como a Barbados, Canadá y Haití, en representación del grupo de países anglosajones y del Caribe. A continuación, se presenta un resumen de las intervenciones de cada país.

Brasil: Sistema único de salud y sistema de información de la fuerza de trabajo en salud

Isabela Cardoso M. Pinto, secretaria de Gestión del Trabajo y Educación en Salud de Brasil, destacó la relevancia de la fuerza de trabajo en salud (FTS) para el funcionamiento del sistema de salud y enfatizó la necesidad de identificar las demandas de RHS según la densidad poblacional y el acceso equitativo a la salud. Su análisis incluyó el mapeo

de las instituciones involucradas en el desarrollo de la FTS y de aspectos clave como la atracción, fijación, retención, distribución, disponibilidad, capacitación y migración de RHS en el país. Brasil dispone de casi tres millones de RHS registrados a través de diversas fuentes de datos, como el registro nacional de establecimientos de salud, los colegios profesionales, el censo nacional de educación superior, distintas entidades regulatorias de salud, u organismos responsables de los servicios de atención primaria de salud y atención hospitalaria, entre otras. De los trabajadores registrados, el 75% son mujeres, el 49% son profesionales, el 37%, técnicos, y el resto, trabajadores con nivel educativo básico. EL SIRHS de Brasil permite analizar la composición de personal en áreas como enfermería, medicina, fisioterapia, farmacia y odontología. Entre las diversas herramientas utilizadas para actualizar el sistema de información se incluyen el censo nacional de trabajadores de la salud y el centro nacional de información de trabajadores de la salud. En cuanto a la utilización de los datos, la doctora Cardoso destacó que la evidencia proporcionada por los SIRHS ha permitido establecer prioridades por territorios, desarrollar una política nacional de gestión de la educación y el trabajo de la salud, y avanzar en la organización de una conferencia internacional sobre el tema.

Cuba: Registro de profesionales y técnicos de la salud

Marcos Agustín del Risco del Río, de la Unidad de Recursos Humanos en Salud, presentó el sistema de salud de Cuba destacando su registro de profesionales y técnicos de la salud, que constituye un sólido sistema de información de RHS. Bajo la rectoría y gestión del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), este sistema integra tres procesos clave correspondientes a los centros formadores, el registro nacional de profesionales del MINSAP y la asignación laboral en establecimientos y redes de salud. Los principales grupos de profesionales registrados son los correspondientes a los profesionales de medicina, estomatología, enfermería y técnicos. El sistema permite gestionar variables por provincia, tipo de profesional, nivel de calificación, lugar de trabajo, edad, especialidad y sexo, entre otras, lo que facilita la medición de la densidad de profesionales y otros aspectos fundamentales para la toma de decisiones. Para el año 2022, Cuba contaba con 94 066 profesionales de medicina registrados y 17 657 estomatólogos, con una tasa de 118 habitantes por profesional de medicina y 627 por profesional de estomatología. Del Risco subrayó la relevancia de los informes generados por el sistema, cuyos análisis son esenciales para apoyar la toma de decisiones.

Barbados: Sistema de información de recursos humanos

Stacie Goring, directora de Planificación e Investigación del Ministerio de Salud y Bienestar de Barbados, explicó que la recolección de datos sobre RHS en su país se realiza a partir de diversas fuentes, como censos de población, encuestas de la fuerza laboral, evaluaciones de instalaciones y bases de datos administrativas. La información también es recopilada por el Consejo de Registro, que incluye además datos demográficos como edad, género y calificaciones de los profesionales de la salud.

Sin embargo, la recolección de datos en Barbados se centra principalmente en la toma de decisiones clínicas y en la información de los pacientes, con un enfoque limitado en los datos relacionados con RHS. A su vez, la gestión de datos sigue siendo un sistema basado en papel, lo que impone restricciones respecto de su control de calidad. Actualmente se están realizando esfuerzos para digitalizar el proceso de registro.

Durante la pandemia de COVID-19, se estableció una unidad especial para gestionar los recursos humanos adicionales reclutados. Esta unidad creó una base de datos para desplegar al personal de manera eficiente durante la crisis, aunque luego se disolvió.

Barbados enfrenta problemas relacionados con la fragmentación de los sistemas, la falta de políticas de gestión de recursos humanos aprobadas y la escasa conexión entre las distintas herramientas digitales. Además, la alta rotación de personal exige una capacitación frecuente. El análisis de datos solo se realiza a demanda, lo que limita el monitoreo de indicadores globales, como la migración de personal.

Barbados busca asistencia técnica para mejorar la recolección, limpieza y validación de datos, así como capacitación en la gestión de datos de múltiples fuentes. También solicita apoyo para enfrentar el desafío de vincular los datos de recursos humanos con la información de salud más amplia, mejorar la interoperabilidad entre las herramientas digitales y proporcionar capacitación continua para el uso de herramientas de las CNPS.

Canadá: Sistema de datos e información de recursos humanos para la salud

Los representantes de Canadá presentaron el Instituto Canadiense de Información sobre la Salud (CIHI, por su sigla en inglés), una organización financiada principalmente por Health Canada. El CIHI es responsable de gestionar y estandarizar los datos de salud en todo el país, garantizando la comparabilidad de datos a nivel nacional.

El sistema de salud canadiense está compuesto por 13 provincias y territorios, cada uno con sistemas de atención independientes, además de un sistema federal que financia los servicios de salud para las comunidades indígenas y las fuerzas armadas. Este modelo federado implica la recolección de datos independientes, y el CIHI desempeña un papel crucial en la recopilación y gestión de estos datos, mediante bases de datos vinculadas que abarcan millones de registros de pacientes.

El CIHI cuenta con el Centro de Excelencia en Datos de la Fuerza Laboral de Salud, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de los datos para facilitar una planificación basada en evidencia. La visión a cinco años del CIHI incluye la creación de un sistema de datos e información sobre RHS modernizado y digitalmente accesible. Dicho sistema apunta a responder a las necesidades del sistema y abordar cuestiones emergentes de políticas de salud relacionadas con los modelos de atención y los cambios demográficos y epidemiológicos, como la atención virtual, el acceso equitativo, el envejecimiento y la salud mental de los pacientes.

Uno de los desafíos que enfrenta Canadá es la fragmentación de datos entre las diferentes jurisdicciones y la necesidad de establecer estándares de datos comparables en todo el país. Para superar estos retos, se requiere inversión en infraestructuras técnicas y desarrollo de metodologías como el “identificador único nacional”, que permitan un recuento preciso y una comprensión más clara de la disponibilidad de la fuerza laboral. También es fundamental la implementación de la metodología del equivalente a tiempo completo, que mide la capacidad de la fuerza laboral de manera más precisa al contabilizar las horas de trabajo en lugar del simple número de empleados, que podría subestimar o sobrestimar su disponibilidad. Este enfoque proporciona una visión más detallada de la capacidad real, lo que facilita la planificación y ayuda a medir la sostenibilidad de la fuerza laboral, evitando los efectos en cadena como el agotamiento y la escasez de personal.

Haití: Desarrollo del sistema de información de recursos humanos para la salud en las Américas

Ketler Guillaume, director de la Dirección de Recursos Humanos para la Salud del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, en su presentación sobre el sistema de información de recursos humanos para la salud (SIGRH, por su sigla en francés) del país destacó que se trata de un sistema digital gestionado a través de Internet, implementado en el 2011 tras un censo del personal de salud. Este sistema proporciona datos individuales sobre el personal de salud, facilita la gestión administrativa y permite generar informes preprogramados que se pueden exportar en formatos como Excel.

Respecto de la gobernanza del SIGRH, los datos son accesibles para oficinas nacionales de estadísticas y asociaciones profesionales, aunque actualmente no existen mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas nacionales o regionales. Se prevé la creación de un comité multisectorial de recursos humanos para la salud en el marco del Master Plan for Health 2021-2031 y el segundo plan estratégico quinquenal de recursos humanos para la salud 2023-2027.

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA) del SIGRH revela fortalezas como la disponibilidad de personal para las operaciones diarias, una red de gestores de RHS y la accesibilidad al sistema desde cualquier ubicación, además de proyectos para extender su funcionalidad al sector privado. Sin embargo, también existen debilidades significativas, como la falta de operatividad de ciertas funcionalidades (por ejemplo, los datos de especialidades de RHS no están disponibles), la gestión de la base de datos por un proveedor privado, infraestructura tecnológica insuficiente, problemas de conexión a Internet y ausencia de un presupuesto para su mantenimiento. Además, está pendiente la digitalización de los archivos del personal, la ampliación de la dotación de técnicos en informática en los puntos focales departamentales y mejoras en la infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación, así como la interoperabilidad con otros sistemas nacionales.

Uno de los desafíos más importantes para la planificación de RHS, basado en los datos disponibles, es la pirámide de edad de los trabajadores de la salud, con una gran proporción que alcanzará la edad de jubilación para el 2030, lo que plantea serios problemas debido al bajo reclutamiento ocasionado por limitaciones presupuestarias.

Módulo 3. Reconocimiento de las cuentas nacionales del personal de salud

En este módulo, se presentó el marco conceptual y operativo de las CNPS: definiciones, conceptos y metodología de medición. A continuación, se presenta un resumen de las dos fases y el ejercicio realizado.

Cuentas nacionales del personal de salud, mapeo de fuentes de datos y actores, y metodología de medición

En línea con la presentación de Boniol, Teena Kunjumen, de la OMS, destacó el papel de las CNPS como un sistema para que los países mejoren progresivamente la disponibilidad, la calidad y el uso de datos, apoyando así el logro de la cobertura sanitaria universal. La implementación de las CNPS se basa principalmente en las necesidades específicas de los países, la diversificación de datos, el fortalecimiento de la gobernanza, la participación activa de los puntos focales y los sistemas nacionales de información, la colaboración mutua, el fomento del uso de datos para la toma de decisiones, la sensibilización sobre los RHS y la movilización de recursos. La información se recopila en una plataforma común de datos de código abierto.

A partir de la experiencia acumulada desde el primer año de implementación (2019), se elaboró una segunda versión de los indicadores de las CNPS, que redujo los módulos de 8 a 4 (densidad, educación, finanzas y políticas). En estos módulos se distribuyeron un total 62 indicadores. Los puntos focales de cada país son responsables de la carga de los datos, aunque se pueden incorporar otros usuarios con distintas funciones, como gerentes, consultores y otros funcionarios, todos ellos con capacidad de visualización e impresión de la información, pero sin permisos para editar los datos.

A continuación, Kunjumen profundizó en los detalles metodológicos para la carga de datos en la plataforma CNPS, enfocándose en las categorías que ofrecen mayor dificultad de conceptualización:

- Niveles totales de trabajadores de la salud y nivel de actividad que desempeñan.
- Propiedad de las instalaciones: públicas, privadas y de otros sectores.
- Tipos de instalaciones: hospitales, centros comunitarios, clínicas, etcétera.

- Migración del personal de salud: lugar de nacimiento y lugar de formación.
- Producción de personal de salud.

Finalmente, como paso previo al ejercicio práctico, se compartieron ejemplos visuales sobre la correcta inclusión de los datos en la plataforma CNPS, utilizando como referencia el módulo de educación del personal de salud. También se describieron algunas definiciones clave de indicadores, como la proporción de trabajadores de la salud, la proporción de trabajadores por grupo de edad y la proporción de trabajadores nacidos en el extranjero.

Ejercicio práctico: temas críticos

Modalidad: trabajo en grupos y por país.

La primera parte de esta actividad práctica consistió en un trabajo grupal enfocado en las categorías más complejas:

- Nivel de actividad en las CNPS.
- Tipo de instalación y propiedad.
- Lugar de nacimiento y lugar de formación.
- Educación.

Cada grupo analizó uno de estos temas identificando particularidades y desafíos, y proponiendo soluciones (imagen 3).

Posteriormente, se realizó un ejercicio individual de introducción de datos en un entorno de prueba de la plataforma CNPS, con datos ficticios sobre los indicadores priorizados.

IMAGEN 3 Participantes del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” durante el ejercicio práctico grupal, Panamá, 2023



© OPS

Módulo 4. Metodología del mapeo de ocupaciones para el desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Una de las oportunidades que ofrece la plataforma CNPS es la de normalizar la información, ajustándola a estándares internacionales. La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (CIUO-08) de la OIT proporciona un listado y una descripción de las ocupaciones en todas las ramas de actividad.

Este módulo del taller estuvo dedicado a las ocupaciones en el ámbito de los RHS. Se presentaron experiencias de diferentes países y se abordó la metodología propuesta para el mapeo de ocupaciones, adaptada a los contextos nacionales. Chile y Costa Rica expusieron sus casos, complementados luego con un análisis sobre las ocupaciones en la Región de las Américas y una actividad práctica entre los participantes.

Chile: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud

La representante de Chile, Claudia Godoy, inició su presentación contextualizando la estructura ministerial y el sistema de salud chileno, que se caracteriza por ser mixto, con una coexistencia de sectores público y privado. Expuso el enfoque estratégico para la planificación de RHS, destacando la necesidad de un sistema de información que permita anticipar los requerimientos de personal en un entorno de salud y organizacional en constante cambio, facilitando así la toma de decisiones.

En cuanto al proceso de registro de ocupaciones del sistema público de salud chileno, Godoy subrayó que la definición primordial de las ocupaciones se basa en un sólido marco legal y regulatorio. Los trabajadores y las agrupaciones de prestadores individuales se registran en la Superintendencia de Salud, lo que conforma la base del SIRHS que abarca a los trabajadores de la salud en todo el país. Chile cuenta con un documento de clasificación de las ocupaciones adaptado de la CIUO 08, que se ajusta a la realidad chilena.

Entre los principales desafíos mencionados se encuentran la interoperabilidad, la homologación de las denominaciones y códigos de ocupaciones, y la importancia de establecer un proceso de registro con responsables encargados de su mantenimiento y validación.

Costa Rica: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud

Gloriana Mora Cascante, jefa de la Unidad de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud, presentó un panorama del sistema nacional de información en recursos humanos para la salud de Costa Rica (SINARHUS), que se caracteriza por la existencia de catálogos que permiten estandarizar los parámetros de una misma variable, facilitando la unificación de las nomenclaturas ocupacionales. El sistema organiza las ocupaciones en categorías y subcategorías que reflejan los niveles de formación profesional, así como en grupos ocupacionales que describen especificidades o calificaciones específicas del personal. La codificación de ocupaciones se basa en la CIUO-08, aunque adaptada a la realidad costarricense. El proceso de adaptación del SINARHUS es dinámico e implica una interacción constante entre el Ministerio de Salud y las diferentes regiones del país. Un aspecto clave es la priorización de un conjunto de ocupaciones a partir del perfil epidemiológico y demográfico de cada territorio. Actualmente, el sistema sigue trabajando para generar una nomenclatura más uniforme, estandarizar los códigos para facilitar la interoperabilidad, incluir nuevas ocupaciones, mantener la plataforma actualizada en tiempo real y automatizar los procesos.

Jamaica: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud

Stephanie Bernard-Stephens y Nastasia Sancko, representantes de Jamaica, presentaron el sistema de clasificación de ocupaciones de Jamaica 2015, que organiza ocupaciones similares obtenidas a partir de censos nacionales en una lista estructurada de categorías. Los principales grupos ocupacionales incluyen gerentes; profesionales técnicos y asociados; trabajadores de apoyo administrativo; trabajadores de servicios y ventas; trabajadores agrícolas, forestales y de pesca; artesanos y trabajadores de oficios relacionados; operadores de plantas y máquinas; ensambladores, y las fuerzas armadas.

Esta clasificación se utiliza como referencia en el Ministerio de Salud y Bienestar, así como en otros ministerios, agencias y departamentos. En el sistema de información y visualización de salud de Jamaica (JaHRvis, por su sigla en inglés), la ocupación de una persona debe seleccionarse de una lista desplegable, sin opción de texto libre.

Jamaica realizó un ejercicio de equivalencia entre su clasificación nacional de ocupaciones y la CIUO-08, lo que ha resultado en una estructura piramidal con cinco niveles distintos, cada uno asignado a un código numérico específico. El nivel superior es el grupo mayor (10), seguido por el subgrupo mayor (código 41), el grupo menor (129), el grupo unitario (442) y, finalmente, el grupo de ocupaciones específicas (1071).

La clasificación actual es altamente específica e incluye miles de opciones, lo que a veces lleva a no completar el campo correspondiente en el JaHRvis, si este no es obligatorio.

Si bien no hay una priorización de ocupaciones a nivel nacional, sí existe una a nivel ministerial. Por ejemplo, la reforma del sistema de atención primaria de salud prioriza la formación de trabajadores de la salud en áreas como salud familiar, salud pública y medicina de emergencia. También se han implementado programas de becas y formación especializada en oncología y subespecialidades, así como en física médica.

Los próximos pasos incluyen la creación de un entorno facilitador enfocado en los RHS, componente clave para lograr la reforma del sistema de atención primaria. El Ministerio de Salud y Bienestar está desarrollando un plan de recursos humanos para la salud, y se avanza hacia un sistema de información electrónica para la salud.

Suriname: Mapeo de ocupaciones en el sistema de salud

En el 2021, Suriname tenía una población de 612 985 personas. Su idioma oficial es el neerlandés, pero se habla una diversidad de lenguas y dialectos debido a la variedad étnica del país, que incluye amerindios, africanos surinameses, caucásicos, libaneses, portugueses, chinos, javaneses, indios y personas de etnias mixtas. La mitad de la población vive en las áreas costeras, mientras que en el interior habitan diferentes tribus, principalmente amerindios y cimarrones.

Muersia Williams, oficial de políticas senior del Ministerio de Salud, informó que el sistema de clasificación ocupacional en Suriname se basa en el análisis funcional y el sistema de información del Gobierno de Suriname (FISO, por su sigla en inglés), que incluye descripciones de puestos y una estructura salarial. Desde el 2010, el FISO se aplica a todas las ocupaciones gubernamentales y del sector semigubernamental y, en algunos casos, también se utiliza como guía en el sector privado. Actualmente, se está desarrollando una nueva estructura para el sector de la salud.

En cuanto al uso de la CIUO-08, Suriname había reconocido y utilizado la versión CIUO-88 a través de la Oficina de Estadísticas de Suriname (ABS, por su sigla en neerlandés). En el 2017, la ABS desarrolló una Ruta Segura para la Integración Socioeconómica, aunque su aplicación en el sector de la salud aún no está clara.

El proceso de comparación y alineación entre la CIUO-08 y el sistema nacional de Suriname comenzó recientemente. Entre los desafíos actuales se encuentran el registro incompleto de todas las ocupaciones del sector de la salud en el Ministerio de Salud, el registro de especialidades duales o múltiples y la incorporación de nuevas ocupaciones, algunas de las cuales son híbridas.

Para aliviar la presión sobre las ocupaciones existentes, las instituciones están desarrollando nuevas posiciones, como la transformación de estudiantes de secundaria en técnicos asistenciales quirúrgicos debido a la falta de enfermeros para los quirófanos.

Suriname también enfrenta escasez en ocupaciones especializadas, como enfermeros neonatales en la unidad de cuidados intensivos y profesionales de medicina especialistas en emergencias, cirugía cardiorácica, neurocirugía y geriatría. El envejecimiento de la población aumenta la necesidad de profesionales de medicina especialistas en geriatría, mientras que la fuga constante de profesionales paramédicos que se van del país inmediatamente después de graduarse complica aún más la situación.

Mapeo de ocupaciones a nivel regional

El mapeo de ocupaciones en la Región de las Américas enfrenta el desafío de articular y armonizar la gran diversidad de clasificaciones ocupacionales presentes en los países. Mario Dal Poz, director del centro colaborador del Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, presentó un análisis de las ocupaciones de la salud en la Región basado en fuentes como sitios web gubernamentales y documentos sobre ocupaciones profesionales, comparándolas con las CNPS y la CIUO-08. La revisión de los sitios web mostró que más del 95% de los países cuenta con una clasificación de las ocupaciones dentro de sus ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Estadística y Gobierno. Sin embargo, solo 29 de los 35 países consultados disponen de un documento formal que defina las ocupaciones profesionales.

Para avanzar con el mapeo de ocupaciones a nivel regional, Dal Poz propuso a los países la importación de sus diferentes clasificaciones ocupacionales a una plataforma común. Como primer paso, invitó a los países a identificar sus ocupaciones tomando como referencia la CIUO-08 y realizando un listado que incluyera tanto las equivalentes como las no equivalentes. A continuación, las ocupaciones con sus denominaciones locales se incorporaron a una planilla dinámica por país, agrupadas según la codificación de las CNPS de la OMS y la CIUO-08. El siguiente paso fue analizar las ocupaciones documentadas para estandarizarlas, evitar duplicados y atender aquellas sin un equivalente en la clasificación. Una vez completada la estandarización y normalización, se realizó una comparación entre las CNPS y las ocupaciones de cada país, para conformar perfiles ocupacionales que pudieran exportarse como informes.

Ejercicio práctico: Mapeo de ocupaciones

La actividad se realizó en pequeños grupos (imagen 4). La primera parte consistió en analizar críticamente y comentar la metodología y las fuentes de datos utilizadas hasta el momento para el mapeo de ocupaciones, así como los resultados obtenidos. Luego, cada país debió identificar, describir y ejemplificar las profesiones

correspondientes a categorías ocupacionales identificadas como prioritarias para la atención primaria de la salud (APS), es decir, trabajadores comunitarios, asistentes y terapeutas dentales, dentistas, farmacéuticos, psicólogos, técnicos de laboratorio y nutricionistas, u otras que considerara cada país. Por último, los resultados se volcaron en un modelo incluido en una hoja de cálculo, previamente normalizada y disponible en la comunidad de práctica del campus virtual de la OPS.

IMAGEN 4 Actividad de trabajo grupal durante el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023



© OPS

Módulo 5. Metodología del mapeo de actores para el desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Durante las presentaciones iniciales del encuentro, se resaltó la importancia de la gobernanza de los SIRHS. Un paso fundamental en la construcción de dicha gobernanza es la identificación y caracterización de los actores que pueden aportar información a los SIRHS.

En este módulo, se invitó a los países a compartir sus experiencias, seguidas de una presentación regional y un ejercicio práctico final.

Belice: Mapeo de los actores en el sistema de recursos humanos para la salud

Lizett Bell, subdirectora de Servicios de Salud y enfermera jefe del Ministerio de Salud y Bienestar de Belice, inició su presentación destacando que, aunque su país es reconocido como parte del Caribe, al estar ubicado en el continente pertenece también a América Central. Tiene una población de aproximadamente medio millón de habitantes, de las cuales el 56% vive en comunidades rurales.

Belice cuenta con una única universidad nacional que ofrece formación para personal de enfermería y salud, pero carece de una escuela de medicina. Los profesionales de medicina se forman en el extranjero, principalmente en América Central, México y Guatemala, con apoyo de Cuba y Taiwán para las especialidades. También se llevan a cabo capacitaciones en la Universidad de las Indias Occidentales y la Universidad Tecnológica de Jamaica, en áreas de enfermería.

Entre los actores clave en el sistema de RHS de Belice se incluyen los consejos y juntas profesionales, el ámbito académico, otros ministerios, además del de Salud, el sector privado y los cuerpos estatutarios. Los consejos profesionales bajo legislación son, entre otros, el Consejo de Enfermeras y Parteras, el Consejo Médico y Dental, y la Junta de Farmacia, que se encuentra en proceso de actualización para exigir registro y educación continua. Los técnicos de salud se registran en el Ministerio de Salud a través de la Unidad de licenciamiento y acreditación.

La Universidad de Belice y sus facultades de ciencias de la salud forman parte del componente académico. El sistema de salud lo financia el Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Educación colabora con becas y oportunidades educativas para los trabajadores de la salud. En cuanto al sector privado, este cuenta con algunas instalaciones de salud medianas y pequeñas. El hospital de referencia a nivel nacional es el Karl Heusner Memorial Hospital, una entidad estatal.

Para el análisis y la planificación de políticas, el Ministerio de Salud recopila datos de RHS a través de distintos mecanismos. Sin embargo, uno de los desafíos principales es la falta de integración del sector privado y la ausencia de un marco legal para la recopilación de datos del personal de salud en este sector.

En el 2022, Belice digitalizó su sistema de gestión de información de recursos humanos mediante una plataforma web. Se lanzó un módulo para el sistema de salud pública y se espera incluir al hospital Karl Heusner en el 2024. Esta herramienta permite la transferencia de datos desde Excel y generar diversos informes y tablas para su análisis.

La actualización continua del sistema implica un reto debido a la movilidad frecuente del personal de salud, las nuevas contrataciones y la persistencia del sistema físico de registro (en papel) en el Ministerio de Servicios Públicos. Para mantenerlo actualizado, se requiere del compromiso de los niveles locales, pero el marcado nivel de transferencias entre personal administrativo responsable demanda capacitaciones recurrentes.

El Salvador: Cuentas nacionales del personal de salud para el año 2022

Paola Alejandra Cea Tenorio, colaboradora técnica de la Dirección de Recursos Humanos, describió a los actores institucionales que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, liderado por el Ministerio de Salud e integrado por nueve entidades: el propio Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Fondo Solidario para la Salud, el Comando de Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, la Dirección Nacional de Medicamentos, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y un representante de los hospitales del sector privado.

Para el proceso de recolección de datos del módulo 1 de las CNPS, participaron el Ministerio de Salud, con 31 hospitales nacionales, cinco direcciones regionales de salud y el nivel central, además de las instituciones de la seguridad social y sanidad militar. Los registros del Consejo Superior de Salud Pública se utilizaron para identificar a todo el personal de salud debidamente inscrito. Se obtuvo información parcial sobre las principales profesiones de la salud en el país, que incluyen a los profesionales de medicina, epidemiología, psicología, fisioterapia, enfermería, odontología, farmacia y nutrición, así como a los promotores de la salud y los trabajadores sociales. Finalmente, la representante de El Salvador expuso los desafíos que enfrenta el ministerio para el desarrollo de su SIRHS, entre ellos: superar la falta de personal para el análisis de datos, establecer alianzas y mecanismos regulatorios para compartir información con otros actores de gobierno involucrados, incorporar el módulo de RHS en el SIRHS, facilitar la accesibilidad para que todos los actores puedan cargar datos en el sistema y realizar un censo nacional del personal de salud.

Paraguay: Sistema nacional integrado de información en recursos humanos para la salud.

Características, procesos y avances

La directora de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud de Paraguay, Cristina Caballero García, inició su presentación describiendo las características, la misión y los procesos de la institución que lidera y su importancia como ente rector y de gobernanza en el ámbito de los RHS. Destacó la importancia de la Política Nacional de RHS del Paraguay 2020-2030 y su plan de implementación, que se estructura en tres lineamientos estratégicos esenciales: *i)* fortalecer y consolidar la rectoría y la gobernanza de políticas y planeamiento estratégico los RHS; *ii)* implementar el Sistema Nacional Integrado de Información en RHS, y *iii)* desarrollar las condiciones y capacidades de los RHS para lograr la cobertura y el acceso universal a la salud con enfoque en APS y Redes Integradas de Servicios de Salud. Caballero García describió los avances normativos y legales que han fortalecido la gobernanza de los SIRHS, como la creación de una mesa técnica nacional, las estrategias de recolección de datos, y los métodos y herramientas tecnológicas para el Sistema Nacional Integrado de Información en RHS, así como el desarrollo de capacidades para la educación mediante un plan nacional de formación y capacitación. En cuanto a la estrategia de comunicación, señaló la importancia de publicaciones nacionales sobre la caracterización de los profesionales de la salud, multiempleo y líneas de base de los RHS. Finalmente, Caballero García analizó las estrategias regulatorias vigentes y la conformación de catálogos de profesionales de medicina, enfermería y odontología.

Mapeo de actores a nivel regional

Isabel Duré, integrante del HSS-HR, presentó un panorama general de los SIRHS, las fuentes de datos disponibles, y la estrategia para el mapeo de actores y cooperación técnica propuesta a los países. Destacó el modelo de estructuración de los SIRHS, basado en registros administrativos de profesionales, establecimientos y usuarios de los sistemas de salud, que de forma progresiva va adquiriendo relevancia frente al modelo tradicional centrado en censos y encuestas. Entre las fuentes de información disponibles, se mencionaron los establecimientos, matriculaciones, certificaciones, titulaciones, legalizaciones, registros de migrantes y contratos de trabajo, así como la información fiscal y las validaciones de identidad de los países.

Respecto del mapeo de actores, destacó que se trata de una metodología que facilita la evaluación del interés, la influencia, el impacto en la política y los recursos de los actores clave para el desarrollo de los SIRHS, y que el objetivo es convocar a dichos actores para el desarrollo de una hoja de ruta común con vistas a un sistema de información integrado. La metodología propuesta consta de los siguientes cuatro pasos: *i)* identificación de los actores; *ii)* análisis normativo; *iii)* entrevistas y diálogos políticos, y *iv)* análisis técnico. El principal resultado de esta metodología es el establecimiento de alianzas y acuerdos para fortalecer los RHS y sus sistemas de información.

Ejercicio práctico: Mapeo de actores

Durante esta actividad, se invitó a los participantes a discutir y compartir en grupos uno de los tres temas principales relacionados con los sistemas de información, para abordarlos a través de la cooperación técnica en sistemas de información de recursos humanos.

Las conclusiones se plasmaron en el foro del CVSP.

Los resultados generales están disponibles en la tercera parte del apartado Conclusiones generales y resultados.

Módulo 6. La Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe

El tercer día del encuentro estuvo dedicado al trabajo conjunto con todos los países de la Región.

Los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) cuentan con una comisión de recursos humanos que trabaja de forma integrada para fortalecer los RHS mediante políticas y acciones estratégicas.

La apertura de esta jornada se centró en compartir los avances de dicha comisión.

La Comisión del Caribe de Recursos Humanos para la Salud

Helen Royer, directora de Desarrollo Humano de la Dirección de Desarrollo Humano y Social de la Secretaría de la CARICOM, presentó la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la CARICOM, que está compuesta por 20 países. De estos, 15 son Estados Miembros y 5 son Estados Asociados, y en total alcanzan una población de aproximadamente 16 millones de personas.

Royer se refirió a los desafíos que enfrenta la subregión, como la escasez de personal esencial, incluyendo profesionales de medicina y enfermería, así como personal de partería. La retención del personal de salud es un problema crítico, ya que muchos emigran en busca de mejores condiciones laborales y financieras. También señaló la falta de especialistas en áreas cruciales como neurología, cardiología y oncología, y una creciente necesidad de profesionales en salud mental y geriatría debido al envejecimiento de la población.

La Comisión se ha planteado mejorar la gobernanza y el liderazgo en el sector de la salud, ya que la capacidad para regular y garantizar la calidad de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, es limitada. Se han priorizado la mejora de la gestión de información, el fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales, y el uso de información estratégica para la toma de decisiones.

La Comisión se estableció en noviembre del 2020 como respuesta a la pandemia de COVID-19 y otras emergencias de salud. Inicialmente, se creó como Grupo de Acción en Recursos Humanos para la Salud (HRH-ATF, por su sigla en inglés). Luego, este se formalizó como una comisión permanente (HRH-CC, por su sigla en inglés).

La Comisión de Recursos Humanos para la Salud trabaja también en la armonización de las regulaciones para los profesionales de la salud y en la capacitación en varios Estados Miembros. Además, se han desarrollado programas de formación en línea y se está trabajando en la revisión de los currículos de enfermería en colaboración con la OPS.

Un reto importante es la sostenibilidad de los programas, ya que muchos se discontinúan una vez que finaliza el financiamiento de los donantes, lo que subraya la necesidad de desarrollar planes de sostenibilidad. Se resaltó la

importancia de la investigación y la aplicación de los resultados para atender las necesidades específicas de los estados miembros.

Por último, la ponente destacó que se está revisando una posible reestructuración de las comisiones y grupos de trabajo para responder de manera más eficaz a las necesidades de los Estados Miembros.

Del Grupo de Acción a la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe: una visión general

Benjamín Puertas presentó la evolución de la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe y su trabajo en temas esenciales sobre la gestión y desarrollo de los equipos de salud en la Región, señalando como un hito la transición del HRH-ATF a una comisión permanente.

La Comisión ha trabajado en colaboración con diversas instituciones, como la Caribbean Public Health Association (CARPHA), la Universidad de las Indias Occidentales y la Universidad de Guyana, en la elaboración de políticas para fortalecer los recursos humanos, con un enfoque particular en la respuesta a pandemias y para abordar la reticencia a la vacunación entre los trabajadores de la salud.

Además, Puertas destacó la importancia que la Comisión otorga a la planificación y previsión de necesidades de RHS, que involucra la utilización de las CNPS. Con el apoyo de la OPS y la OMS, se definieron indicadores esenciales para monitorear y mejorar la fuerza laboral de salud en la Región.

La educación y la capacitación también fueron aspectos fundamentales, con la creación de programas de formación en línea y el equipamiento de laboratorios de simulación en varios países miembros. Los avances de la Comisión se basaron en lograr la participación activa de los países y en la colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales. Sin embargo, también se enfrentaron desafíos, como la limitación de recursos financieros y una participación desigual entre los países.

Una iniciativa clave fue el lanzamiento del Americas Health Corps, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y la OPS, con el objetivo de capacitar a 500 000 trabajadores de la salud en América Latina y el Caribe en un plazo de cinco años. Este programa, respaldado con financiamiento inicial, busca fortalecer los sistemas de salud nacionales y abordar problemas críticos como la migración de trabajadores de la salud.

La Comisión se enfoca en el fortalecimiento de los RHS mediante políticas y acciones estratégicas, la colaboración internacional y el desarrollo de capacidades educativas, en un esfuerzo por mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud en la Región.

Indicadores básicos de recursos humanos para la salud en el Caribe

La Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe tiene entre sus tareas monitorear y asesorar sobre temas prioritarios relacionados con los RHS, incluida la migración de trabajadores de la salud. Además, busca alinear las políticas nacionales de RHS con las estrategias regionales.

Fiona Harris, consultora internacional de la OPS para el Caribe, explicó el conjunto de indicadores básicos y suplementarios acordados inicialmente por la HRH-ATF, basados en los indicadores de las CNPS de la OMS. Se conformó una lista de 30 indicadores, que se implementan mediante el sistema de CNPS.

Los indicadores, que se seleccionaron en función de la viabilidad de la recolección de datos, el número de actores involucrados y su importancia para las necesidades de la Región, se agrupan en tres niveles:

- Nivel 1: comprende 13 indicadores básicos que todos los países deben alcanzar.
- Nivel 2: contiene 13 indicadores suplementarios para los países que ya hayan cumplido con el nivel 1.
- Nivel 3: incluye 3 indicadores adicionales para aquellos países que hayan completado los niveles anteriores.

El nivel 1 abarca indicadores relacionados con la fuerza laboral de salud activa, educación y capacitación, características del empleo, gobernanza y SIRHS. El nivel 2 comprende indicadores relacionados con las existencias y el flujo de trabajadores, la regulación de la formación y los flujos del mercado laboral de salud. El nivel 3 se centra en las salidas voluntarias e involuntarias del personal en el mercado laboral de salud, así como en las tasas de vacantes.

El objetivo de este acuerdo sobre indicadores es proporcionar a los países del Caribe datos esenciales para tomar decisiones informadas sobre los RHS. Sin embargo, los países enfrentan desafíos como la falta de sistemas de información de RHS completos, la recolección de datos ineficiente y fragmentada y capacidades limitadas en las áreas de recursos humanos para la salud dentro de los ministerios. Además, pocos países cuentan con planes y estrategias nacionales de RHS que prioricen este tema.

Harris destacó la colaboración entre la Comisión y estadísticos de varios países, que resultó en un plan de acción para implementar los indicadores de RHS. Para su puesta en marcha, se identificaron áreas prioritarias esenciales como la gobernanza, el desarrollo de capacidades, los sistemas de gestión de información sobre la salud y el uso estratégico de datos.

El uso de herramientas y recursos proporcionados por la OPS, la OMS y el CVSP puede ayudar a fortalecer las capacidades y mejorar la situación de los RHS en el Caribe.

Módulo 7. Metodología de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Las distintas áreas de la OPS responsables de los indicadores de RHS trabajan de manera interprogramática para optimizar la recolección de información y mejorar la calidad de los datos publicados. En colaboración con el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, se articula información sobre diversas profesiones de la salud, como medicina, enfermería, odontología, farmacéutica y áreas técnicas, aprovechando las buenas prácticas en el desarrollo de los sistemas de información.

Este enfoque sienta las bases para la implementación de la herramienta de evaluación de la madurez de los SIRHS, que se presenta en este módulo.

Sistemas de información para la salud. Marco conceptual, modelo de madurez de los sistemas de información para la salud y desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud de las Américas

Andrea Gerger, asesora del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, presentó el marco conceptual de los sistemas de información para la salud (IS4H, por su sigla en inglés) que impulsa la OPS, así como su modelo de madurez (IS4H-MM). La iniciativa IS4H integra el Plan de Acción para el Fortalecimiento

de los Sistemas de Información para la Salud 2019-2023 aprobado por los Estados Miembros de la OPS, y se diseñó para mejorar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en la Región mediante el fortalecimiento de sistemas de información interconectados e interoperables. Su principal propósito es generar información de calidad que permita mejorar la toma de decisiones médicas, de gestión y de políticas de salud, y de acuerdo con esto se estructura en torno a cuatro objetivos estratégicos: *i)* gestión de datos y tecnologías; *ii)* gestión y gobernanza; *iii)* innovación y rendimiento, y *iv)* gestión e intercambio de conocimientos. Cada objetivo involucra componentes clave para asegurar la efectividad del IS4H. A su vez, la OPS dispone de políticas, herramientas de evaluación, documentos, guías, materiales educativos y una comunidad de práctica para cooperar con los países en el desarrollo de sus sistemas de información de salud. Respecto de la herramienta IS4H-MM, se trata de un modelo de análisis de madurez que implementa evaluaciones a nivel nacional mediante un sistema informático basado en los cuatro objetivos estratégicos y sus componentes. El modelo cuenta con cinco niveles de madurez, de los cuales la gestión e intercambio de conocimientos es el más avanzado en la Región. Finalmente, Gerger destacó la utilidad que ofrecen los resultados del modelo como herramienta para establecer prioridades estratégicas y planes de trabajo en el marco de la iniciativa IS4H; como insumo y enfoque para la mejora de procesos en las diversas áreas de IS4H; como base para el monitoreo continuo de la capacidad de IS4H y la mejora de procesos; como insumo crítico para la transformación digital del sector de la salud, y como punto de referencia de la madurez de IS4H para que otras autoridades sanitarias nacionales de América Latina y el Caribe adopten mejores prácticas (imagen 5).

IMAGEN 5 Presentación del modelo de madurez IS4H en el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023



© OPS

Tomando como referencia la iniciativa del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, la Unidad de Recursos Humanos para la Salud ha desarrollado una propuesta de herramienta para evaluar la madurez de los sistemas de información. En este marco, como parte del desarrollo del taller, se invitó a los representantes de Bahamas, Panamá y Uruguay a que presentaran el estado de madurez de sus SIRHS, y luego se llevó a cabo la presentación y validación de la herramienta para evaluar la madurez de los SIRHS a nivel regional.

Bahamas: El Comité Nacional de Recursos Humanos y Trabajadores de la Salud

Paul Haven, vicepresidente de recursos humanos del Doctor's Hospital Nassau, expuso acerca del Comité Nacional de Recursos Humanos y Trabajadores de la Salud de Bahamas y se refirió a los cuatro objetivos estratégicos que este ha definido, que son: *i)* fortalecer y consolidar la gobernanza y el liderazgo en RHS, estableciendo relaciones transversales sólidas; *ii)* optimizar el desempeño del personal de salud; *iii)* implementar un sistema de información del personal de salud, y *iv)* facilitar el desarrollo y el financiamiento de una política y un plan de acción nacionales de RHS. En este marco, señaló que la iniciativa IS4H ha permitido relacionar el componente de los RHS con otras áreas esenciales, como la prestación de servicios, la gobernanza, las tecnologías sanitarias, la infraestructura y el financiamiento. En relación con el proceso de evaluación de la madurez del SIRHS, Bahamas aplicó el modelo IS4H-MM de la OPS, abarcando los siguientes dominios: *i)* gestión de datos y tecnologías; *ii)* gestión y gobernanza; *iii)* innovación y rendimiento, y *iv)* gestión e intercambio de conocimientos. El país obtuvo una valoración de entre 2 y 3, sobre un total de 5 niveles. Las principales lecciones aprendidas del proceso de evaluación fueron: el fortalecimiento de mejores prácticas, los dominios y componentes de IS4H; la actualización del marco jurídico y normativo nacional; el establecimiento de normas y procedimientos operativos normalizados; el refuerzo de la coordinación y la planificación nacionales mediante la gobernanza colaborativa y la definición de prioridades; el establecimiento de líneas de comunicación más efectivas, y la identificación de necesidades y asignación de recursos financieros acordes.

Panamá: El sistema de información de recursos humanos de salud: un pilar fundamental en el desarrollo del sistema de salud y la construcción de políticas

Dianne Torres Quintero, planificadora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, presentó los antecedentes del SIRHS de Panamá. Explicó que inicialmente se trabajaba de manera manual con hojas de cálculo de Excel, utilizando variables no estandarizadas que generaban numerosos problemas. Ante esta situación, se planteó el objetivo de digitalizar y modernizar la información sobre la fuerza laboral del sector de la salud para mejorar la toma de decisiones en los ámbitos administrativos, de gestión de recursos humanos y servicios de salud a nivel nacional, subnacional y local. En la actualidad, el país dispone de una plataforma tecnológica para el manejo del SIRHS, así como de un tablero de resultados que muestra los principales reportes de los indicadores.

Los indicadores para el SIRHS fueron extraídos del *Manual de medición y monitoreo de indicadores de las metas regionales de recursos humanos para la salud*¹ y la *Política nacional de salud y lineamientos estratégicos 2016-2025*² de la República de Panamá. Estos indicadores se centran en aspectos como la densidad de profesionales de la salud por cada 10 000 habitantes (profesionales de medicina y enfermería, y personal de partería), o la razón de profesionales de medicina por habitante que se desempeñan en la APS (profesionales de medicina

¹ Organización Panamericana de la Salud. *Manual de medición y monitoreo de indicadores de las metas regionales de recursos humanos para la salud*. Washington, D.C.: OPS; 2011. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/31099>.

² Ministerio de Salud de la República de Panamá. *Política nacional de salud y lineamientos estratégicos 2016-2025*. Panamá: Ministerio de Salud; 2016. Disponible en: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/pan174954.pdf>.

generalistas/profesionales de medicina especialistas; profesionales de enfermería/profesionales de medicina; la densidad específica de diferentes tipos de profesionales por cada 1000 habitantes, o la distribución de profesionales y otros trabajadores de la salud, por competencias). En relación con la evaluación de la madurez del SIRHS, se aplicó el modelo de madurez del IS4H, con resultados positivos en la gestión de datos, gobernanza e intercambio de conocimientos.

Uruguay: Evaluación de la madurez del sistema de información

María Lucía Aicardi, miembro del Ministerio de Salud, planteó la importancia que tienen los recursos humanos para la salud en el proceso asistencial a la población, al representar aproximadamente el 70% del gasto en salud y el 7% del total de personas ocupadas en Uruguay. Destacó el objetivo del Ministerio de Salud de consolidar su rol rector mediante los SIRHS, una prioridad para Uruguay en su esfuerzo por fortalecer esta área.

Al respecto, Aicardi explicó que el SIRHS en su país cuenta con un sistema de habilitación y registro de profesionales de la salud, que regula el registro de títulos como medida de control. El sistema incluye los registros administrativos de mercado de trabajo del personal del Ministerio de Salud Pública, entidades descentralizadas de emergencias, servicios altamente especializados y otros centros públicos o privados que aportan información por medio de sus bases de datos. Además, destacó que los registros administrativos del ministerio cubren más del 72% de los trabajadores de la salud.

En relación con la madurez del SIRHS, Aicardi describió las categorías esenciales de evaluación: *i)* gestión de datos; *ii)* tecnologías de la información, y *iii)* rectoría y gobernanza. Los niveles de avance varían según las áreas evaluadas: existencias y flujo (11 de 12 grados), educación (5 de 13 grados), gasto y financiamiento (2 de 5 grados) y condiciones laborales, gobernanza y liderazgo (23 de 28 grados). A modo de conclusión, resaltó que Uruguay ha consolidado un fuerte rol rector en lo referente a sistemas de información, con un enfoque en el desarrollo de herramientas coercitivas para la generación de datos del sector. Si bien se han logrado importantes avances, no se ha alcanzado un sistema de información unificado, por lo que resta aún avanzar hacia una planificación conjunta de los RHS.

Presentación de la propuesta del modelo de madurez del sistema de información de recursos humanos para la salud a nivel regional

Michele Guillou, consultora internacional de la Unidad de Recursos Humanos de la OPS, analizó el concepto de “modelo de madurez” y lo definió como un estado de desarrollo pleno, en el que una organización, proceso o proyecto alcanza el máximo nivel de desempeño. El modelo de madurez para los SIRHS presentado por Guillou toma como referente el IS4H-MM de la OPS. Sin embargo, a diferencia de este, que consta de cinco niveles progresivos, el modelo de madurez para los SIRHS se compone de cuatro niveles.

El diseño de este modelo se basó en las siguientes características: la autoevaluación, su alineación con las CNPS, la eficiencia en términos de tiempo y efectividad, su potencial para fortalecer los planes de los SIRHS, y la utilización progresiva. El modelo se estructuró en torno a tres áreas estratégicas: *i)* gestión de datos y tecnologías de información (GDTI); *ii)* gestión y gobernanza (GEGO), y *iii)* conocimientos y toma de decisiones (COTD). Para cada una de estas áreas, se establecieron cuatro niveles de madurez (del 1 al 4). La herramienta para su implementación se desarrolló mediante hojas de cálculo.

Finalmente, Guillou puntualizó algunas sugerencias clave para cuantificar el nivel correspondiente a cada SIRHS de los países de la Región y propuso una actividad para validar el modelo con los presentes.

Ejercicio práctico: Modelo de madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Se conformaron mesas de trabajo grupales y se orientó a los participantes para discutir y compartir opiniones sobre:

- 1. La estructura del instrumento.
- 2. Preguntas específicas relacionadas con cada una de las tres áreas estratégicas del instrumento.

La herramienta, diseñada en una hoja de cálculo, se utilizó para un ejercicio de evaluación de la madurez. Esta herramienta incluye una pestaña de inicio con orientaciones e información general, una pestaña para cada área estratégica con sus respectivos cuatro niveles, y una última pestaña con un glosario de términos y conceptos (imagen 6). También se facilitó un documento con pautas de validación para guiar mejor el ejercicio.

IMAGEN 6 Captura de pantalla de la herramienta diseñada para evaluar la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud, Panamá, 2023

 	
Medición y Análisis de Madurez de los Sistemas de Información de Personal de Salud - PROPUESTA PARA VALIDACION 05/09/2023	
Áreas Estratégicas	Nota 1: Instrumento adaptado de la herramienta de Medición de Madurez de Sistemas de Información en Salud, IS4H, desarrollada por la OPS y OMS
	Nota 2: Instrumento basado en las Cuentas Nacionales de Personal de Salud
	Instrucciones para usar la herramienta de análisis de la madurez de los SIRHS:
1. Gestión de datos y tecnologías de la información (GDTI)	1. Guarde este documento con el nombre de su país o institución y la fecha.
2. Gestión y gobernanza (GEGO)	2. Proporcione la información que se pide debajo sobre el perfil de la organización.
3. Conocimientos y toma de decisión (COTD)	3. Responda a cada pregunta de las tres categorías (áreas estratégicas) seleccionando el número que mejor describa la situación actual de su organización en la columna "Nivel".
Proporcione la siguiente información sobre su organización:	
Nombre(s)	
Fecha	
Ubicación	
Organización	
Información adicional	
Inicio GDTI GEGO COTD Glosario	

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Campus Virtual de Salud Pública [sitio web]. Washington, D.C.: OPS. Disponible en: <https://campus.paho.org/es>.

Los grupos consideraron apropiada la herramienta para evaluar la madurez de los SIRHS y realizaron aportes para su mejora dentro de la comunidad de práctica para el fortalecimiento de los SIRHS, disponible en el CVSP (imagen 7).

IMAGEN 7 Participantes del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, durante el trabajo grupal, Panamá, 2023



© OPS

TERCERA PARTE

Desafíos y prioridades de los países de la Región para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

A través de la comunidad de práctica del CVSP, se llevó a cabo una consulta sobre los desafíos y las prioridades para el desarrollo y fortalecimiento de los SIRHS en cada uno de los países, con el objetivo de orientar la cooperación técnica (cuadros 2 y 3). Los resultados reflejan necesidades y requerimientos que abarcan diversas áreas de la gestión de recursos humanos para la salud.

Desafíos y prioridades de los países de América Latina

Bolivia (Estado Plurinacional de)

1. Actualizar la política y elaborar un plan de acción de RHS, en el que el sistema de recursos humanos sea una de las estrategias clave. Para lograr este documento nacional, se debe tomar en cuenta el mapeo de actores y sistemas de información desarrollado en el 2021 por el consultor Juan Lucas Pereyra.
2. Desarrollar la integración de los sistemas de información de los subsectores de la seguridad social a corto plazo, incluyendo los sectores público y privado.
3. Implementar un catálogo para optimizar el sistema de registro profesional del país, con la participación de los sectores pertinentes liderados por un comité nacional de recursos humanos.

Chile

1. Desde la perspectiva de la cooperación técnica, y teniendo en cuenta la realidad local, los principales desafíos se relacionan con la implementación de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, lo que implica la homologación de nomenclaturas y códigos.
2. Además, es fundamental recibir apoyo para incrementar la visibilidad de estos temas en el país, ya que se requiere el respaldo de las autoridades para avanzar en la coordinación intersectorial y en la toma de decisiones clave.

Costa Rica

1. Implementar una comunicación estratégica con enfoque en la gestión del cambio, dirigida a los actores responsables de generar la información para el monitoreo de la política.
2. Recibir asesoría en la construcción de indicadores intermedios y operativizar la recolección de datos, para lograr una adecuada medición de indicadores establecidos, con énfasis en la validación y la calidad.

3. Actualmente, estas son las dos líneas de cooperación identificadas, ya que el país se encuentra en el proceso de desarrollo y aprobación de la política. Sin embargo, tras esta etapa, es posible que se requiera apoyo en otros aspectos, para fortalecer tanto la política como los SIRHS.
4. Además, se ha identificado la necesidad de apoyo técnico para evaluar la madurez del sistema de información existente en el país.

Cuba

1. Apoyo en la capacitación continua de los funcionarios y directivos a cargo de la gestión de recursos humanos en los diferentes niveles del sistema nacional de salud.
2. Contribuir a la unificación de los sistemas de información.
3. Fortalecer la informatización en la gestión de los sistemas de información.

Ecuador

1. Actualmente se está trabajando en la Política Nacional de Recursos Humanos, para lo cual es fundamental abordar los puntos críticos que requieren un apoyo:
 - Deserción de recursos humanos.
 - Aprovechamiento ineficiente del personal.
 - Baja productividad.
 - Dicotomía entre los sectores público y privado.

Guatemala

1. Desarrollar un catálogo común que incluya a todas aquellas instituciones capaces de proporcionar información, lo que permitiría mejorar la calidad de la información.
2. Elaborar un registro nacional de RHS.
3. Constituir marcos legales que establezcan la obligatoriedad de la entrega de datos, ya que con frecuencia no se cuenta con la información necesaria por falta de voluntad de los actores para entregarla.
4. Contar con una política de recursos humanos aprobada.
5. Fortalecer la gobernanza del Ministerio de Salud sobre otros actores, como la seguridad social, universidades, colegios profesionales y servicios privados.

Panamá

1. Apoyo técnico para avanzar en la implementación del SIRHS en el Ministerio de Salud y brindar asesoría técnica para fomentar la colaboración con otros actores del sector de RHS, como la Caja de Seguro Social, patronatos y entidades de formación (universidades estatales y privadas).
2. Asesoría técnica para el desarrollo estratégico del Plan Nacional de Recursos Humanos de Panamá.
3. Apoyo técnico para actualizar la situación del recurso humano (diagnóstico, brecha y caracterización).

Paraguay

1. Continuar con las cooperaciones orientadas a cumplir con la estrategia 3 de la *Política nacional de recursos humanos en salud del Paraguay 2020-2030*,³ en particular, con la implementación del sistema nacional de información estratégica de los recursos humanos para la salud.

³ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Organización Panamericana de la Salud. Política nacional de recursos humanos en salud del Paraguay 2020-2030. Asunción: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 2021. Disponible en: <https://www.mspps.gov.py/dependencias/portal/adjunto/43b0d2-POLITICANACIONALDERECURSOSHUMANOSSENSALUDELPARAGUAY.pdf>.

2. Planificar, integrar y estandarizar un sistema de información estratégico sobre RHS, que proporcione datos para la gestión, planificación y toma de decisiones, con un enfoque que abarque todo el sistema nacional de salud, para avanzar en los siguientes temas:
 - Creación de un registro integrado, alimentado por múltiples fuentes primarias, que permita incluir de forma sincronizada información de todo el sistema nacional de salud a través del Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Paraguay.
 - Estandarización de los registros electrónicos entre instituciones.
3. Interoperabilidad entre los sistemas de información para intercambiar los datos.

Perú

1. Armonizar el catálogo de ocupaciones en el país.
2. Favorecer la aprobación de un marco normativo (actualmente en proceso de revisión por la autoridad nacional de salud) que establezca la obligatoriedad del registro nacional de personal de salud por parte de las instituciones.
3. Promover la interoperabilidad del registro nacional de personal de salud con el sistema de datos (aplicación) de la oficina de migraciones.

República Dominicana

1. Definir la gobernanza del sistema de información de RHS, especificando roles, periodicidad de recolección de datos, procesos de monitoreo, seguridad de la información, interoperabilidad, protección de datos, ciberseguridad, y que el propio sistema integre fuentes primarias.
2. Lanzar una campaña de comunicación estratégica para posicionar el tema tanto dentro como fuera del Ministerio de Salud.
3. Apoyo técnico para el desarrollo e implementación del SIRHS, que incluya georreferenciación, autorregistro, procesos de validación, consultas externas y medidas de ciberseguridad, integrando también temas de migración.
4. Recibir apoyo en el proceso de elaboración del primer censo de RHS.

Uruguay

1. Promover la difusión de las CNPS, así como de sus resultados y utilidades, para lograr una mayor apropiación de estas por parte de las autoridades sanitarias y aumentar la adhesión a los sistemas de información.
2. Incorporar en los sistemas de información a algunos actores del sector de la salud de los que aún no se ha logrado obtener datos, como clínicas privadas de estética, oftalmología, odontología, laboratorios, establecimientos de larga permanencia, farmacias, entre otros.
3. Establecer lazos para fortalecer la interoperabilidad con otras bases de datos, como las de seguridad social, defunciones o del Ministerio de Educación.

CUADRO 2 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en los países de América Latina, por orden de prioridad, 2023

Requerimiento/país	BOL	CHI	COR	CUB	DOR	ECU	GUT	PAN	PAR	PER	URU	Total
Políticas y planes de recursos humanos para la salud (RHS)												6
Elaborar política de RHS							4					1
Fortalecer/actualizar política de RHS	1		3			1 ^a						3
Elaborar plan de acción de RHS	1											1
Elaborar plan nacional de RHS								2				1
Marcos normativos												2
Elaborar marcos legales/normativos para establecer obligatoriedad en la entrega de información							3			2		2
Gobernanza												4
Fortalecer la gobernanza del Ministerio de Salud							5					1
Comunicar de forma estratégica la importancia y utilidad de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS)			1		2						1	3
Desarrollo/fortalecimiento de SIRHS												3
Fortalecer/implementar SIRHS					3			1	1			3
Interoperabilidad												7
Lograr interoperabilidad e integración sectorial en los sistemas de información	2	1		2				1	3	3	3	7
Desarrollo de catálogo/registro												8
Desarrollar catálogo común entre sectores	3						1					2
Captar datos de otros sectores									2		2	2
Elaborar registro nacional de RHS					4		2					2
Homologar y catalogar ocupaciones		2								1		2
Asuntos operativos												2
Construir indicadores intermedios, operativizar la recolección de información			2									1
Fortalecer la informatización en la gestión del SIRHS				3								1
Mantenimiento, uso y gobernanza del SIRHS												3
Mejorar la gobernanza del sistema de información					1							1

CUADRO 2 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en los países de América Latina, por orden de prioridad, 2023 (continuación)

Requerimiento/país	BOL	CHI	COR	CUB	DOR	ECU	GUT	PAN	PAR	PER	URU	Total
Evaluar la madurez del sistema			4									1
Utilización de datos								3				1
Desarrollo de RHS en general												1
Capacitar de forma continua y general en temas de RHS				1								1

Nota: BOL: Bolivia (Estado Plurinacional de); CHI: Chile; COR: Costa Rica; CUB: Cuba; DOR: República Dominicana; ECU: Ecuador; GUT: Guatemala; PAN: Panamá; PAR: Paraguay; PER: Perú; URU: Uruguay.

^a Incluye subtemas como desertión de RHS, aprovechamiento ineficiente del personal, baja productividad o dicotomía entre los sectores público y privado.

Fuente: OPS.

Desafíos y prioridades de los países del Caribe y Canadá

Anguila

1. Apoyo técnico de la OPS para asistir al Ministerio de Salud en el desarrollo de políticas para el sistema integrado de RHS, con el fin de fortalecer la gestión de datos.
2. Capacitación proporcionada por la OPS *in situ*, que ayude a identificar al personal clave para colaborar en el desarrollo y mantenimiento del sistema.
3. Elaborar un plan estratégico para abordar la fragmentación de datos y desarrollar un sistema semiautomatizado e integrado que actualice regularmente a las autoridades con información relevante, precisa y oportuna.

Antigua y Barbuda

1. Contar con conocimiento especializado para respaldar y mantener el sistema.
2. Incorporar a un especialista en tecnologías de la información.
3. Contratar a un especialista en sistemas de información de la salud e historia clínica.
4. Soporte para los usuarios.

Bahamas

1. Capacitar a los principales actores involucrados en la gestión y el análisis de datos.
2. Aumentar la interoperabilidad de los sistemas de información en todo el sistema de salud.
3. Garantizar la infraestructura y el *hardware* necesarios para cumplir con los objetivos.

Barbados

1. Asistencia en la actualización de la política y el plan de acción de RHS del país.
2. Asistencia en la implementación de las recomendaciones derivadas del IS4H-MM, particularmente en el desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la Salud 2019-2023.
3. Evaluación del SIRHS, mediante recomendaciones adecuadas y un plan de acción.
4. Capacitación del personal del Consejo de Registro de Barbados lo antes posible en el uso de las CNPS.
5. Fortalecer la capacidad para vincular los datos de RHS con información sobre salud más amplia, como las necesidades de la población, la utilización de servicios y los resultados de los pacientes.
6. Asistencia en la identificación de un sistema digital de información en salud adecuado para respaldar el SIRHS.

Belice

1. Promover el desarrollo de capacidades relacionadas con las CNPS con todas las partes involucradas.
2. Crear infografías y perfiles para las diferentes categorías de RHS.
3. Elaborar perfiles de RHS para los diferentes niveles de atención.
4. Capacitaciones a los miembros del sector político en el uso de las CNPS.
5. Establecer un mecanismo para realizar análisis del mercado laboral de los trabajadores de la salud.

Canadá

1. Microsimulación y proyección en la planificación.

Dominica

1. Asistencia en la redacción y elaboración de la política de recursos humanos.
2. Fortalecimiento de las capacidades para la capacitación que facilite la participación y el uso de las CNPS y el acceso sostenible a la capacitación dentro del contexto nacional.
3. Facilitar intercambios técnicos enfocados en el aprendizaje continuo y el desarrollo de programas de RHS.

Granada

1. Normalización de los instrumentos de recolección de datos.
2. Capacitación de los actores fundamentales en la gestión de la información.

Guyana

1. Normalización de herramientas y metodologías para la recolección de datos.
2. Desarrollo de capacidades para involucrar a los puntos focales y actores centrales de la Región en la recopilación de datos.
3. Asistencia técnica para la creación de una unidad de RHS dentro del Ministerio de Salud.
4. Apoyo técnico para la gestión de personal en el sector de la salud.
5. Apoyo técnico para la elaboración de un plan de trabajo con instituciones académicas orientado a la formación de recursos humanos.
6. Apoyo técnico para reestructurar la formación en salud y la función de la Unidad de Ciencias de la Salud con el objetivo de establecer una institución nacional dedicada al desarrollo del personal de salud.

Islas Turcas y Caicos

1. Implementación de programas de formación y desarrollo de capacidades a largo plazo para garantizar que el país disponga de la experiencia necesaria para gestionar de manera independiente las operaciones del SIRHS.
2. Capacitación en procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar que los datos recopilados y gestionados en el SIRHS cumplan con altos estándares de precisión y confiabilidad.
3. Interoperabilidad para garantizar que el SIRHS sea capaz de intercambiar datos con otros sistemas de información de la salud y bases de datos, tanto a nivel nacional como potencialmente con sistemas regionales o internacionales.

Islas Vírgenes Británicas

1. Apoyo técnico en la recopilación de los datos necesarios para construir los sistemas de información.
2. Capacitación adicional para el punto focal de las Islas Vírgenes Británicas, ya que actualmente no hay ninguna en marcha.

Jamaica

1. Finalización del marco y la política de RHS y su correspondiente plan de implementación.
2. Mapeo de ocupaciones y actores clave en el sector de la salud.

3. Capacitación en la introducción de datos en las CNPS.
4. Desarrollo de un sistema nacional de información de RHS que incluya la cooperación del sector privado.
5. Formación continua sobre las CNPS.

Montserrat

1. Formación de los actores principales en materia de SIRHS.
2. Asistencia técnica para el desarrollo de una política nacional de RHS.
3. Apoyo técnico para mejorar la operatividad de los sistemas de información a nivel local.

Saint Kitts y Nevis

1. Asistencia técnica para el desarrollo del sistema digital de RHS.
2. Apoyo técnico para la actualización del plan de acción de RHS.
3. Asistencia técnica para capacitar a los actores y partes interesadas en la recolección de datos de indicadores de RHS y CNPS.

San Vicente y las Granadinas

1. Revisión, actualización y ampliación de la política y el plan de acción nacional de recursos humanos, incluyendo los costos.
2. Desarrollo de un plan de implementación para la estrategia SIRHS.
3. Capacitación de formadores para los puntos focales de RHS y SIRHS.
4. Apoyo para la integración del SIRHS en el sistema de información de la salud.
5. Cooperación Técnica para continuar con la implementación del SIRHS.
6. Aumento de la capacidad de los puntos focales.
7. Posible creación de una unidad de recursos humanos.

Santa Lucía

1. Desarrollo de una política o estrategia de SIRHS que incluya la adopción de títulos, códigos y descripciones de puestos estandarizados en todas las agencias involucradas.
2. Revisión del SIRHS propuesto o recientemente implementado para determinar su capacidad de proporcionar los datos de indicadores necesarios y los análisis requeridos para la toma de decisiones (¿es viable como está?, ¿necesita algún tipo de personalización o se requiere una solución totalmente nueva?).
3. Revisión del SIRHS propuesto o recientemente implementado para determinar si permite un acceso adecuado a los datos por parte de los actores interesados, y si produce estadísticas e indicadores fiables para la toma de decisiones.

Suriname

1. Asistencia para el desarrollo de la política o estrategia de RHS.
2. Apoyo para la implementación del SIRHS, alineándolo con las CNPS.
3. Fortalecimiento de capacidades mediante capacitaciones al Ministerio de Salud y otros actores interesados.
4. Finalización del desarrollo e implementación del SIRHS a nivel nacional.
5. Capacitación del personal del Ministerio de Salud y de las partes involucradas en los SIRHS en el país.
6. Desarrollo del plan de acción de RHS para el país.

Trinidad y Tabago

1. Estandarización de las herramientas de captura de datos.
2. Formación y sensibilización de los actores pertinentes.
3. Desarrollo de la política de RHS.

CUADRO 3 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en el Caribe y Canadá, por orden de prioridad, 2023

Prioridad/país	ANI	ANU	BAH	BAR	BLZ	CAN	DOM	GRA	GUY	JAM	MOT	SAL	SAV	SCN	SUR	TCA	TRT	VIB	Total
Políticas y planes RHS																			10
Elaboración de la política de recursos humanos para la salud (RHS)		1					1			1	2				1		3		6
Desarrollo de un plan de acción de RHS															3				1
Actualización de la política y/o el plan de acción de RHS				1									1	2					3
Gobernanza de los RHS																			7
Creación de Unidad de RHS en el Ministerio de Salud									3				7						2
Creación de una institución nacional para el desarrollo de RHS									6										1
Sensibilización sobre sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) y cuentas nacionales del personal de salud (CNPS)					1						1				2		2		4
Plan de desarrollo de SIRHS																			3
Desarrollo del plan estratégico de SIRHS		3											2						2
Desarrollo del plan de acción de Sistemas de Información para la Salud (IS4H, por su sigla en inglés)				2															1

CUADRO 3 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en el Caribe y Canadá, por orden de prioridad, 2023 (*continuación*)

Prioridad/país	ANI	ANU	BAH	BAR	BLZ	CAN	DOM	GRA	GUY	JAM	MOT	SAL	SAV	SCN	SUR	TCA	TRT	VIB	Total
Desarrollo de SIRHS																			6
Desarrollo de SIRHS		2								4			5	1	1, 2				6
Sostenibilidad de SIRHS																			8
Formación para el mantenimiento y el soporte de SIRHS	1		3	6							3					1			5
Identificación del conocimiento especializado para el soporte de SIRHS	2, 3, 4																		3
Recolección de datos																			6
Establecimiento de estándares para recolección de datos								1	1								1		3
Desarrollo de capacidades para la recopilación de datos									2					3				1	3
Desarrollo de capacidades																			11
Formación en la plataforma CNPS				4	4		2	2		3, 5			3, 6		2			2	10
Formación en aseguramiento de la calidad																2			1
Visualización/ utilización de datos																			6
Utilización de datos para la toma de decisiones			1	5	2, 3							2, 3							6

CUADRO 3 Resumen de necesidades y requerimientos de cooperación técnica en recursos humanos para la salud en el Caribe y Canadá, por orden de prioridad, 2023 (*continuación*)

Prioridad/país	ANI	ANU	BAH	BAR	BLZ	CAN	DOM	GRA	GUY	JAM	MOT	SAL	SAV	SCN	SUR	TCA	TRT	VIB	Total
Interoperabilidad																			5
Interoperabilidad			2									1				3			3
Integración de SIRHS en Sistemas de Información para la Salud													4						1
Mapeo de ocupaciones y actores										2									1
Evaluación																			1
Evaluación de SIRHS				3															1
Planificación																			2
Microsimulación y proyección						1													1
Planificación de RHS									4										1
Otros RHS																			3
Análisis del mercado laboral					5														1
Desarrollo de un plan de formación de RHS en conjunto con el ámbito académico									5										1
Formación general de RHS							3												1

Nota: ANI: Antigua y Barbuda; ANU: Anguila; BAH: Bahamas; BAR: Barbados; BLZ: Belice; CAN: Canadá; DOM: Dominica; GRA: Granada; GUY: Guyana; JAM: Jamaica; MOT: Monserrat; SAL: Santa Lucía; SAV: San Vicente y las Granadinas; SCN: Saint Kitts y Nevis; SUR: Suriname; TCA: Islas Turcas y Caicos; TRT: Trinidad y Tabago; VIB: Islas Vírgenes Británicas.

Fuente: OPS.

CUARTA PARTE

Resultados y conclusiones

Breve síntesis sobre el desarrollo del taller

El taller se realizó en dos etapas: la primera, con participantes de América Latina, y la segunda, con participantes del Caribe. Formaron parte todos los países de la Región, a excepción de dos que no enviaron representantes. Además del equipo regional, estuvieron presentes dos responsables del equipo de las CNPS de la OMS (anexo 3).

La agenda se repitió el primer y el segundo día del taller para los países de América Latina y del Caribe, y luego se compartió un día con todos los participantes (anexos 1 y 2). El miércoles fue una jornada de trabajo conjunto para toda la Región. El programa se organizó en cuatro módulos dedicados a distintos temas: Sistemas de información y CNPS, Mapeo de ocupaciones, Madurez de los sistemas de información y Mapeo de actores. Cada módulo contó con dos presentaciones de países, una presentación conceptual por parte de expertos y una actividad de trabajo en grupo. El equipo de CNPS de la OMS, junto con el equipo regional, ofreció una capacitación en la plataforma y asistió a algunos participantes para subir sus datos durante el taller. El equipo del CVSP colaboró en llevar el registro de las discusiones grupales y compartió el material a través de la plataforma Moodle.

Resultados

Gracias a la organización y los módulos programados, se lograron los resultados esperados, además de identificar nuevos desafíos y prioridades para la cooperación técnica en los países que brindaron sus aportes:

- Análisis de la situación regional y global de los SIRHS.
- Reconocimiento, intercambio y capacitación de los países sobre el marco y la metodología de las CNPS.
- Metodología para el mapeo de las ocupaciones de la salud, con compromiso de los países para su utilización.
- Propuesta de una metodología para el mapeo de actores clave en la construcción de los SIRHS, presentada y discutida con los países.
- Validación de la metodología para la evaluación de la madurez de los SIRHS.
- Identificación y registro de los desafíos y prioridades de los países para fortalecer los SIRHS en la comunidad de práctica del CVSP.

Conclusiones

Se observaron importantes diferencias entre los países respecto de sus avances en la construcción y gobernanza de sus sistemas de información, lo que resalta la necesidad de adaptar la cooperación a las circunstancias de cada país.

Durante el taller, los representantes de los países examinaron el mapeo de ocupaciones en el sector de la salud, compartiendo experiencias y estrategias para mejorar la precisión y exhaustividad de los registros. El objetivo de este debate fue obtener una visión más completa y actualizada de la fuerza laboral de salud. Se destacó

la importancia de categorizar las ocupaciones de manera consistente para mejorar la gestión de los recursos humanos para la salud.

La evaluación de la madurez de los SIRHS fue un tema central del taller. Los participantes intercambiaron información sobre el estado actual de desarrollo de sus sistemas, identificando desafíos y oportunidades para mejorar su efectividad, y destacaron la importancia de la implementación de la herramienta de evaluación de la madurez.

También se debatió la necesidad de invertir en tecnología y capacitación para garantizar que los sistemas satisfagan las crecientes demandas del sector de la salud. Los participantes compartieron sus avances en la recopilación y el análisis de datos, resaltando la importancia de monitorear de cerca el tamaño y la composición de la fuerza laboral de salud. Además, la discusión abordó el desafío de utilizar estos datos para la toma de decisiones informadas sobre políticas de salud y planificación estratégica.

En cuanto al mapeo de actores, los participantes exploraron estrategias para identificar los distintos actores involucrados en la gestión de RHS, incluyendo instituciones de formación, organismos reguladores, sindicatos y otros aliados clave. El enfoque se centró en el fortalecimiento de la gobernanza mediante la colaboración y la coordinación entre las partes interesadas, con el objetivo de alcanzar una gestión más eficiente y eficaz del personal de salud.

Los países tuvieron la oportunidad de registrar sus necesidades y prioridades de cooperación técnica. Todo el material y las sugerencias están disponibles en el CVSP.

El taller constituyó un encuentro valioso para promover la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los países de la Región, y generar redes para el mejoramiento de la gestión de los RHS.

Cada uno de los temas discutidos contribuyó a avanzar en la comprensión y la capacidad de acción de los sistemas de salud, especialmente en América Latina y el Caribe.

Recomendaciones

- Continuar brindando acompañamiento directo a los países que presentan mayores dificultades en sus sistemas de información, especialmente en el Caribe, pero también en países como Honduras, en Centroamérica, o Bolivia (Estado Plurinacional de), en América del Sur.
- Promover la realización de ejercicios de mapeo de actores y evaluación de la madurez de los sistemas de información en los países de la Región, fomentando además el intercambio de buenas prácticas.
- Desarrollar e implementar la metodología y las herramientas para el mapeo de actores, la evaluación de la madurez de los SIRHS y el mapeo de ocupaciones de la salud, con el fin de facilitar el desarrollo de SIRHS en los países de la Región.
- Continuar fortaleciendo la carga de información en las CNPS y avanzar con el mapeo de ocupaciones a nivel regional, asegurando que cada país disponga de una visión particular, pero alineada con las CNPS.
- Apoyar a los países en la comunicación efectiva de la información disponible, ya sea mediante la publicación de artículos o a través de otras formas de comunicación.
- Analizar en profundidad las demandas de cooperación técnica registradas por los países en el CSVP y aplicar las metodologías presentadas en el taller, ajustándolas a la realidad y necesidades específicas de cada entorno particular.

Anexos

Anexo 1.

Agenda del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” para los países de América Latina, 11-13 de septiembre de 2023

Día 1: 11 de septiembre

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
8:00-8:30	Registro de los participantes	
8:30-9:20	Palabras de apertura y bienvenida	Benjamín Puertas, Organización Panamericana de la Salud (OPS) Leah-Mari Richards, OPS, Panamá Dagoberto Vega, Ministerio de Salud, Panamá
9:20-10:30	Agenda global. Cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) Perspectiva y prioridades regionales: evidencia, información y conocimiento de recursos humanos para la salud (RHS) en las Américas	Mathieu Boniol, Organización Mundial de la Salud (OMS) Gisele Almeida, OPS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-11:30	Sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) en la Región • Brasil • Cuba	Moderadora: Isabel Duré, OPS
11:30-12:30	Perspectivas regionales: datos e información de RHS • Descripción general de las respuestas de las encuestas de usuarios • Validación de indicadores básicos para América Latina	Isabel Duré, OPS Ana Paula Cavalcante de Oliveira, OPS Mariana Lopes Galante, OPS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-13:50	Registro en la comunidad de práctica del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP)	Johel Díaz, CVSP, OPS Edgardo de Gracia, CVSP, OPS

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
13:50-14:50	Cuentas nacionales del personal de salud • Implementación de CNPS (participación de las partes interesadas y fuentes de datos) • Segunda versión de los indicadores de las CNPS • Portal de datos de las CNPS	Teena Kunjumen, OMS Moderadora: Gisele Almeida, OPS
14:50-15:10	CNPS: cuestiones críticas • Niveles de actividades • Tipos de gestión/financiamiento: sector público, privado y otros • Educación y otros sectores • Tipo de instalaciones: hospital, centro comunitario, clínicas, etcétera • Lugar de nacimiento y lugar de formación	Teena Kunjumen, OMS
15:10-15:30	CNPS: trabajo en grupo de temas críticos	Equipos de la OPS y la OMS
15:30-15:45	Pausa café	
15:45-16:00	CNPS: Trabajo en grupo de temas críticos (continuación) • Comentarios al plenario	Equipos de la OPS y la OMS
16:00-17:30	Capacitación sobre la plataforma CNPS • Entrada de datos (carga por lotes en línea y en Excel) • Visualización y extracción de datos • Completamiento y envío de datos • Trabajo en grupo por país en la plataforma	Teena Kunjumen, OMS Mathieu Boniol, OMS Ana Paula Cavalcante, OPS Mariana Lopes Galante, OPS

Día 2: 12 de septiembre

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
8:30-9:10	Mapeo de ocupaciones • Chile • Costa Rica	Moderadora: Gisele Almeida, OPS
9:10-10:30	Mapeo de ocupaciones • Metodología	Mario Dal Poz, centro colaborador de la OMS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-12:30	Mapeo de ocupaciones • Trabajo en grupo	Equipos de la OPS y la OMS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-14:10	Mapeo de actores • El Salvador • Paraguay	Moderadora: Isabel Duré, OPS

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
14:10-15:00	Mapeo de actores • Metodología propuesta • Trabajo en grupo (fuentes de información, sistemas de información, datos disponibles, clasificación estandarizada, etcétera)	Isabel Duré, OPS
15:00-15:15	Pausa café	
15:15-17:00	Mapeo de actores • Trabajo en grupo y presentaciones	Moderadora: Ana Paula Cavalcante, OPS

Día 3: 13 de septiembre

Horario	Actividades conjuntas con todos los países de las Américas	Disertante/presentador/moderador
8:00-8:30	Inscripción (solo para participantes ingleses del Caribe, Estados Unidos y Canadá)	
8:30-9:00	Palabras de apertura y bienvenida (participantes del Caribe, Estados Unidos y Canadá) Foto de grupo con todos los participantes	Benjamín Puertas, OPS Leah-Mari Richards, OPS, Panamá
9:00-10:15	Madurez del SIRHS • Marco conceptual y modelo de madurez de Sistemas de Información para la Salud (IS4H, por su sigla en inglés) • Bahamas • Panamá • Uruguay	Andrea Gerger, OPS Moderadora: Gisele Almeida, OPS
10:15-10:30	Registro en la comunidad de práctica del CVSP	Johel Díaz, OPS Edgardo de Gracia, OPS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-12:15	Metodología para la evaluación de la madurez del SIRHS • Metodología propuesta • Trabajo en grupo • Validación	Michele Guillou, OPS Moderadora: Isabel Duré, OPS
12:15-12:30	Cierre para los puntos focales de países de América Latina	Benjamín Puertas, OPS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-17:30	Consulta sobre la plataforma CNPS (abierta a todos los puntos focales de CNPS) • Entrada de datos en la plataforma • Portal CNPS • Consultas	Mathieu Boniol, OMS Teena Kunjumen, OMS Ana Paula Cavalcante, OPS Mariana Lopes Galante, OPS

Anexo 2.

Agenda del taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas” para los países del Caribe inglés, Canadá y Estados Unidos, 13-15 de septiembre de 2023

Día 1: 13 de septiembre

Horario	Actividades conjuntas con todos los países de las Américas	Disertante/presentador/moderador
8:00-8:30	Inscripción (solo para participantes ingleses del Caribe, Estados Unidos y Canadá)	
8:30-9:00	Palabras de apertura y bienvenida (participantes del Caribe, Estados Unidos y Canadá) Foto de grupo con todos los participantes	Benjamín Puertas, Organización Panamericana de la Salud (OPS) Leah-Mari Richards, OPS, Panamá
9:00-10:15	Madurez del sistema de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) • Marco conceptual y modelo de madurez de Sistemas de Información para la Salud (IS4H, por su sigla en inglés) • Bahamas • Panamá • Uruguay	Andrea Gerger, OPS Moderadora: Gisele Almeida, OPS
10:15-10:30	Registro en la comunidad de práctica del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP)	Johel Díaz, OPS Edgardo de Gracia, OPS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-12:15	Metodología para la evaluación de la madurez del SIRHS • Metodología propuesta • Trabajo en grupo • Validación	Michele Guillou, OPS Moderadora: Isabel Duré, OPS
12:15-12:30	Cierre para los puntos focales de países de América Latina	Benjamín Puertas, OPS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-17:30	Consulta sobre la plataforma Cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) (abierta a todos los puntos focales de CNPS) • Entrada de datos en la plataforma • Portal CNPS • Consultas	Mathieu Boniol, Organización Mundial de la Salud (OMS) Teena Kunjumen, OMS Ana Paula Cavalcante, OPS Mariana Lopes Galante, OPS

Día 2: 14 de septiembre

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
8:30-9:45	Perspectiva global: CNPS Perspectiva y prioridades regionales: evidencia, información y conocimiento de los recursos humanos para la salud (RHS)	Mathieu Boniol, OMS Gisele Almeida, OPS
9:45-10:30	Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la Comunidad del Caribe (CARICOM) Hoja de ruta de la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la CARICOM Indicadores básicos de RHS de la Comisión de Recursos Humanos para la Salud de la CARICOM	Benjamín Puertas, OPS Helen Royer, CARICOM Fiona Harris-Glenville, OPS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-11:25	SIRHS • Barbados • Canadá	Moderadora: Annella Auer, OPS
11:25-12:30	Perspectiva regional: datos e información de recursos humanos • Resumen de las respuestas de la encuesta de usuarios • Análisis de indicadores de la región	Ana Paula Cavalcante, OPS Mariana Lopes Galante, OPS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-14:00	CNPS • Implementación de CNPS (participación de las partes interesadas y fuentes de datos) • Segunda versión de los indicadores de las CNPS • Portal de datos de las CNPS	Teena Kunjumen, OMS Moderadora: Annella Auer, OPS
14:00-14:20	CNPS: cuestiones críticas • Introducción • Niveles de actividades • Propiedad de las instalaciones: sector público, privado y otros • Educación y otros sectores • Tipo de instalaciones: hospital, centro comunitario, clínicas, etcétera • Lugar de nacimiento y lugar de formación	Teena Kunjumen, OMS Moderadora: Ana Paula Cavalcante, OPS
14:20-14:50	CNPS: trabajo en grupo sobre cuestiones críticas • Comentario del plenario	Equipos de la OPS y la OMS
14:50-15:30	Capacitación de las CNPS	Equipos de la OPS y la OMS
15:30-15:45	Pausa café	
15:45-17:30	Capacitación sobre la plataforma CNPS • Entrada de datos (carga por lotes en línea y en Excel) • Visualización y extracción de datos • Completamiento y envío de datos • Trabajo en grupo por país en la plataforma	Equipos de la OPS y la OMS

Día 3: 15 de septiembre

Horario	Actividad	Disertante/presentador/moderador
8:30-9:10	Mapeo de ocupaciones • Jamaica • Suriname	Moderador: Gisele Almeida, OPS
9:10-10:30	Mapeo de ocupaciones • Metodología	Mario Dal Poz, centro colaborador de la OMS
10:30-10:45	Pausa café	
10:45-12:30	Mapeo de ocupaciones • Trabajo en grupo y presentaciones	Equipos de la OPS y la OMS
12:30-13:30	Almuerzo	
13:30-14:10	Mapeo de actores • Belice • Guayana	Moderadora: Annella Auer, OPS
14:10-15:00	Mapeo de actores • Metodología • Trabajo en grupo (fuente de información, sistemas de información, datos disponibles, clasificación estandarizada, etcétera)	Isabel Duré, OPS
15:00-15:15	Pausa café	
15:15-17:00	Mapeo de actores • Trabajo en grupo y presentaciones	Moderadora: Ana Paula Cavalcante, OPS
17:00	Cierre	Gisele Almeida, OPS Leah-Mari Richards, OPS, Panamá

Anexo 3.

Representantes de los distintos puntos focales en el taller regional “Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas”, Panamá, 2023

N.º	País/filiación	Nombre	Cargo/institución
1	Anguila	Jacqueline Bryan-Niles	Secretaria permanente de salud en funciones, Ministerio de Salud
2	Antigua y Barbuda	Indira Roberts	Especialista en sistemas de información para la salud
3	Bahamas	Paul Haven	Vicepresidente de Recursos Humanos, Doctor's Hospital Nassau
4	Barbados	Stacie Goring	Directora, Unidad de Planificación e Investigación, Ministerio de Salud y Bienestar
5	Barbados	Dawn Barrow	Director, Sistemas de Información
6	Belice	Lizett Bell	Directora adjunta, Servicios de Salud, jefa de Enfermería, Ministerio de Salud y Bienestar
7	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Silvia Cuentas Canaza	Profesional, Unidad de Recursos Humanos, Ministerio de Salud y Deportes
8	Brasil	Décio Santiago da Silva Jr.	Profesor adjunto, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ)
9	Brasil	Mario Dal Poz	Profesor titular, Instituto de Medicina Social, UERJ
10	Brasil	Isabela Cardoso de Matos Pinto	Secretaria, Secretaría de Gestión del Trabajo y Educación en Salud (SGTES), Ministerio de Salud (MS)
11	Brasil	Bruno Guimarães de Almeida	Director, Departamento de Gestión y Regulación del Trabajo en Salud (DEGERTS), SGTES, MS
12	Brasil	Marcelo Marques Lima	Consultor del DEGERTS, SGTES, MS
13	Canadá	Patrick Cyr	Director, Grupo de Acción de Recursos Humanos para la Salud, Subdivisión de Política Estratégica, Health Canada
14	Canadá	Kathy Lee	Directora, Recursos Humanos para la Salud, equipo de Gestión de Datos, Instituto Canadiense de Información para la Salud
15	Chile	Claudia Godoy	Profesional, División de Gestión de Personas, Ministerio de Salud
16	Colombia	Laura Galvis	Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
17	Costa Rica	Gloriana Mora Cascante	Jefa de la Unidad de Recursos Humanos en Salud, Dirección de Servicios en Salud, Ministerio de Salud
18	Cuba	Marcos del Risco del Río	Unidad de Recursos Humanos en Salud

N.º	País/filiación	Nombre	Cargo/institución
19	Dominica	Vernanda Raymond	Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud
20	Ecuador	Monserath López	Directora nacional de Fortalecimiento Profesional y Carrera Sanitaria
21	El Salvador	Paola Alejandra Cea Tenorio	Colaboradora técnica, Dirección de Recursos Humanos
22	Granada	Tishanna Smart	Oficial administrativo superior de recursos humanos
23	Guatemala	Luis Felipe García Ruano	Dirección de Formación, Educación e Investigación en Salud
24	Guyana	Helen Royer	Directora de Desarrollo Humano, Comunidad del Caribe
25	Guyana	Rahual Lildhar	Economista, Ministerio de Salud
26	Haití	Ketler Guillaume	Director, Dirección de Recursos Humanos para la Salud, Ministerio de Salud Pública y Población
27	Honduras	Isnaya Nuila Zapata	Directora, Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
28	Islas Turcas y Caicos	Frankira Forbes	Ministerio de Salud
29	Islas Vírgenes Británicas	Dierdra Wheatley-Peters	Directora, Recursos Humanos en Servicios para la Salud
30	Jamaica	Nastasia Sancko	Analista de salud digital
31	Jamaica	Stephanie Bernard-Stephens	Analista de planificación de la salud, División de Política, Planificación y Desarrollo
32	Montserrat	Arlene Ponteen	Director, Servicios de Atención Secundaria de la Salud
33	Nicaragua	Christian Amaru Ramos Benavides	Analista "A" de sistemas de computación, Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
34	Panamá	Dagoberto Pino	Jefe, Departamento de Planificación e Investigación de Recursos Humanos
35	Panamá	Johel Díaz	Especialista en Campus Virtual
36	Panamá	Dianne Torres Quintero	Médica, planificadora de Recursos Humanos, Ministerio de Salud
37	Paraguay	Cristina Caballero García	Directora, Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud
38	Perú	Javier Cesar Loayza Altamirano	Equipo técnico, Dirección Ejecutiva de Planificación, Ministerio de Salud
39	República Dominicana	Nuranni Reyes García	Directora, Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
40	Saint Kitts y Nevis	Kishma Cranstoun Nisbett	Oficial administrativo, Ministerio de Salud
41	Saint Kitts y Nevis	Candida Richards	Oficial administrativo, Ministerio de Salud
42	San Vicente y las Granadinas	Simone Keizer-Beache	Médico jefe, Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente
43	San Vicente y las Granadinas	Neilon Henry	Administrador de bases de datos, Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente
44	San Vicente y las Granadinas	Whilma Ryan	Oficial administrativo segundo, Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente

N.º	País/filiación	Nombre	Cargo/institución
45	Santa Lucía	Kevin Harris	Ministerio de Salud
46	Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA)	Melissa Hernández	SE-COMISCA
47	Suriname	Muersia Williams	Oficial de políticas senior, Ministerio de Salud
48	Trinidad y Tabago	Sonia Seecharan-Raphael	Directora general, Recursos Humanos, Autoridad Sanitaria Regional del Este
49	Uruguay	María Lucía Aicardi	Punto Focal, Cuentas Nacionales de Recursos Humanos en Salud, Ministerio de Salud
50	Venezuela (República Bolivariana de)	Eulices Rojas	Director general, Oficina de Gestión Humana, Ministerio del Poder Popular para la Salud
51	Organización Mundial de la Salud (OMS)	Mathieu Boniol	OMS
52	OMS	Teena Kunjumen	OMS
53	Programa Subregional para América Central y República Dominicana (CAM)	Katiuska Alvayero	Consultor nacional del CAM, Organización Panamericana de la Salud (OPS)
54	OPS/OMS	Naail Uthman	Profesional nacional, refuerzo de los sistemas sanitarios, Guyana
55	OPS/OMS	Ana Paula Cavalcante	Consultora internacional, OPS
56	OPS/OMS	Andrea Gerger	Especialista en Sistemas de Información y Gestión de Datos, Unidad de Sistemas de Información y Salud Digital, Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud
57	OPS/OMS	Annella Auer	Experta y consultora internacional, Comunidad del Pacífico (SPC) y Centro de Referencia Bacteriológica (CRB), OPS
58	OPS/OMS	Armando De Negri	Asesor, Sistemas y Servicios de Salud, México
59	OPS/OMS	Carlos Yuri Ayala Cerna	Asesor, Sistemas y Servicios de Salud, Nicaragua
60	OPS/OMS	María Fernanda Meneses	Consultora nacional, Costa Rica
61	OPS/OMS	Caroline Chang	Asesora, Sistemas y Servicios de Salud, Honduras
62	OPS/OMS	Cristiane Gosh	Consultora nacional, Brasil
63	OPS/OMS	Daniel Albrecht	Asesor, Sistemas y Servicios de Salud, Guyana
64	OPS/OMS	Benjamín Puertas	Jefe, Unidad de Recursos Humanos para la Salud
65	OPS/OMS	Evelyn Martínez Cruz	Consultora nacional, Cuba
66	OPS/OMS	Felipe Sánchez	Consultor nacional, Recursos Humanos para la Salud, OPS, Bolivia (Estado Plurinacional de)
67	OPS/OMS	Fiona Harris-Glenville	Consultora internacional de Recursos Humanos en Salud, Unidad de Recursos Humanos para la Salud, OPS

N.º	País/filiación	Nombre	Cargo/institución
68	OPS/OMS	Fredy Canchihuamán	Consultor nacional, Sistemas y Servicios de Salud, OPS, Perú
69	OPS/OMS	Gabriel Listovsky	Campus Virtual de Salud Pública, OPS, Panamá
70	OPS/OMS	Gilma Ramos	Consultora nacional, Sistemas y Servicios de Salud, El Salvador
71	OPS/OMS	Gisele Almeida	Asesora, Sistemas de Salud e Investigación Política, OPS, Panamá
72	OPS/OMS	Hernán Sepúlveda	Asesor, Recursos Humanos para la Salud, Programa Subregional para América del Sur, OPS, Perú
73	OPS/OMS	Ileana Fleitas	Asesora, Sistemas y Servicios de Salud, Venezuela (República Bolivariana de)
74	OPS/OMS	Isaías Montilla	Consultor nacional, Sistemas y Servicios de Salud, Panamá
75	OPS/OMS	Javier Uribe	Asesor, Sistemas y Servicios de Salud, Ecuador
76	OPS/OMS	Joel Caraballo	Consultor internacional, OPS
77	OPS/OMS	Leah-Mari Richards	Asesora, Sistemas y Servicios de Salud, Panamá
78	OPS/OMS	María Isabel Duré	Consultora internacional, OPS
79	OPS/OMS	Mariana Lopes	Interna, OPS
80	OPS/OMS	Michele Guillou	Consultora internacional, Unidad de Recursos Humanos para la Salud, OPS
81	OPS/OMS	Monica Duraes	Consultora nacional, Brasil
82	OPS/OMS	Oristela Canto	Asistente administrativa
83	OPS/OMS	Rosmond Adams	Asesor, Sistemas y Servicios de Salud, Suriname
84	OPS/OMS	Rita de Carol	Asistente administrativa, Panamá
85	OPS/OMS (Red de Rehabilitación Basada en Comunidad [CRB, por su sigla en inglés])	Karen Gladbach	Consultora internacional, Programa Subregional para el Caribe (SPC-CRB, por su sigla en inglés) de la OPS

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son esenciales para gestionar de manera eficiente el personal de salud y formular políticas basadas en evidencia. Sin embargo, muchos países enfrentan dificultades para integrar estos sistemas, lo que dificulta la planificación y el monitoreo de la fuerza laboral. La fragmentación de los datos representa un reto que puede superarse mediante una mayor coordinación con las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS).

En septiembre del 2023, se llevó a cabo un taller sobre SIRHS con más de 90 participantes de 35 países y territorios. Durante el evento, se identificaron importantes brechas en el desarrollo y la gobernanza de estos sistemas, lo que exige una cooperación adaptada a las necesidades de cada país. Uno de los temas centrales fue el mapeo de ocupaciones en salud, donde se resaltó la importancia de una categorización coherente para optimizar la gestión de los recursos humanos.

También se debatió el grado de madurez de los SIRHS, intercambiando experiencias sobre los desafíos y oportunidades para fortalecerlos. Se destacó la necesidad de invertir en tecnología y capacitación para responder a las crecientes demandas del sector. Además, se abordó el mapeo de actores clave en la gestión de recursos humanos, promoviendo la colaboración y la mejora de la gobernanza.

El taller fomentó la cooperación entre países, facilitando el intercambio de conocimientos y el desarrollo de guías y otros materiales para apoyar el avance de los SIRHS en América Latina y el Caribe.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

www.paho.org